

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Aplicación del Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría

Autores:

Denisse Andrea Méndez Orellana

Camila Michelle Pallango Astudillo

Director:

Marco Leonardo Peralta Zúñiga

ORCID:  0000-0003-4552-0432

Cuenca, Ecuador

2024-03-22

Resumen

Los servicios hospitalarios abarcan numerosos recursos que necesitan de una gestión eficiente para poder otorgar una prestación garantizada y de calidad. El proyecto integrador se centra en la aplicación del Sistema de Costos basado en Actividades (ABC) dentro del Hospital San Juan de Dios específicamente en el Área de Quirófano. El objetivo principal es proporcionar una herramienta para el manejo eficiente y eficaz de los recursos, de modo que se provea una visualización minuciosa de los costos en cada actividad. La investigación trata acerca del proceso desarrollado en el Área de Quirófano, destacando los servicios de las cirugías más relevantes para el Hospital. Se realiza un análisis pormenorizado de los subprocesos, actividades, recursos y sus costos asociados. La metodología planteada del Modelo ABC permite asignar los costos incurridos por cada actividad de forma exacta. La recopilación de datos denota sobre el tiempo dedicado o el consumo de recursos en cada actividad. El producto de la investigación finaliza con una descripción acerca de la estructura de costos en el Área de Quirófano referidas a las cirugías más representativas, lo cual permitirá al Hospital la identificación de oportunidades para la eficiencia operativa y mejora en la toma de decisiones estratégicas. Además, se proponen recomendaciones para optimizar los costos sin desvalorizar la calidad de los procedimientos quirúrgicos.

Palabras clave: análisis de costos, eficiencia operativa, eficiencia empresarial.



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

Hospital services encompass numerous resources that require efficient management to ensure guaranteed and high-quality provision. This integrative project focuses on implementing the Activity-Based Costing (ABC) system within San Juan de Dios Hospital, specifically in the Operating Room Area. The primary objective is to provide a tool for the efficient and effective management of resources, offering a detailed visualization of costs for each activity. The research delves into the processes within the Operating Room Area, highlighting the most relevant surgical services for the hospital. A detailed analysis is conducted on subprocesses, activities, resources, and their associated costs. The proposed ABC Model methodology enables the precise allocation of costs incurred by each activity. Data collection focuses on the time dedicated to each activity and the consumption of resources. The research output concludes with a description of the cost structure in the Operating Room Area, specifically related to the most representative surgeries. This allows the hospital to identify opportunities for operational efficiency and improvements in strategic decision-making. Furthermore, recommendations are proposed to optimize costs without compromising the quality of surgical procedures. The findings of this research contribute to the advancement of resource management practices in hospital settings.

Keywords: Cost analysis, operational efficiency, business efficiency.



The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de Contenido

Resumen	2
Abstract	3
Agradecimiento	9
Dedicatoria.....	10
Introducción	11
Justificación	13
Planteamiento del Problema.....	14
Objetivos.....	15
Objetivos Generales	15
Objetivos Específicos.....	15
Capítulo I.....	16
1.1 Aspectos Generales.....	16
1.1.1 Reseña histórica de la organización	16
1.1.2 Misión	16
1.1.3 Visión.....	16
1.1.4 Objetivos institucionales	17
1.1.5 Valores	18
1.2 Cartera de Servicios.....	19
1.2.1 Consulta Externa	19
1.2.2 Servicios Hospitalarios.....	19
1.3 Estructura organizacional de la empresa.....	22
Capítulo II.....	23
2.1 Marco Teórico.....	23
2.1.1 Antecedentes de la investigación.....	23
2.2 Marco Conceptual.....	28
2.2.1 Definición Costos	28
2.2.2 Contabilidad de Costos	28
2.2.3 Elementos del Costo	29
2.2.4 Sistemas de Costeo	29
2.2.5 Sistema de costos Basado en Actividades ABC	30

2.2.6 Definiciones básicas del modelo.....	31
2.2.7 Ventajas y desventajas.....	32
2.3 Diseño Metodológico.....	33
2.3.1 Tipo de Investigación.....	33
2.3.2 Método de investigación	33
2.4 Metodología Utilizada para el Modelo ABC	34
2.4.1 Levantamiento del proceso.....	34
2.4.2 Identificación y clasificación de las actividades.....	34
2.4.3 Identificación de los recursos invertidos	34
2.4.4 Asignación de los recursos directos a los objetos de costo	35
2.4.5 Determinación de inductores de costos de los recursos	35
2.4.6 Asociación de los recursos indirectos a las actividades.....	35
2.4.7 Asignación de costos de las actividades a los Servicios (objetos de costos)	35
2.4.7 Cálculo de los costos totales	36
Capítulo III.....	37
3.1. Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios".....	37
3.2. Descripción del Área de Quirófano	37
3.3 Diseño del modelo ABC del área de Quirófano	39
3.3.1 Levantamiento del proceso.....	39
3.3.2 Identificación y clasificación de las actividades.....	39
3.3.3 Identificación de los recursos invertidos	40
3.3.4 Asignación de los recursos directos a los objetos de costo	41
3.3.5 Determinación de inductores de costos de los recursos	42
3.3.6 Asociación de los recursos indirectos a las actividades.....	43
3.3.7 Asignación de costos de las actividades a los Servicios (objetos de costos)	58
3.3.8 Cálculo de los costos totales	60
Conclusiones.....	62
Recomendaciones.....	65
Referencias.....	66
Anexos	68
Anexo A: Acuerdo de Confidencialidad	68

Anexo B: Ficha de Procesos.....	75
Anexo C: Registro de Tiempo de Procesos	82
Anexo D: Entrevistas.....	87
Anexo E: Diagrama de Flujos de Subprocesos y Actividades	90
Anexo F: Honorarios Médicos Estandarizados	91
Anexo G: Listado Estandarizado de Medicamentos e Insumos	96
Anexo H: Tiempo de Funcionamiento de las Máquinas.....	97
Anexo I: Tiempo de Realización de Actividades de Enfermeras	97
Anexo J: Costo del Recurso Consideración de los Metros Cuadrados.....	98
Anexo K: Número de Personas E Instrumentos que Intervienen en las Actividades	99
Anexo L: Consumo de Energía de las Máquinas.....	99
Anexo M: Cantidad de medida de Kilovatios-Hora que Consume cada Actividad...	103
Anexo N: Horas de Consumo de Gases Medicinales en el Quirófano	104
Anexo Ñ: Representatividad del Costo de Muebles y Enseres	104
Anexo O: Representatividad del Costo de Máquina, Equipo y Tecnología	105
Anexo P: Central de Cirugía- Quirófanos.....	106
Anexo Q: Protocolo del Proyecto integrador.....	107

Índice de Figuras

Figura 1. Organigrama del Hospital San Juan de Dios	22
Figura 2. Cirugías realizadas en el año 2022.....	38

Índice de Tablas

Tabla 1. Cirugías realizadas en el año 2022	38
Tabla 2. Subprocesos y Actividades	39
Tabla 3. Recursos invertidos.....	40
Tabla 4. Recursos directos	41
Tabla 5. Recursos Comunes y sus inductores	42
Tabla 6. Recurso Específico	43
Tabla 7. Asignación de Costos de Medicamentos e Insumos	43
Tabla 8. Asignación de Costos de Arriendo de Equipos.....	44
Tabla 9. Asignación de Costos de Mantenimiento.....	46
Tabla 10. Asignación de Costos de Sueldos y salarios, Beneficios sociales y otros.....	47
Tabla 11. Asignación de Costos de Servicio de Agua Potable	49
Tabla 12. Asignación de Costos de Servicio de Energía Eléctrica	50
Tabla 13. Asignación de Costos de Servicio de Internet y Uniformes del personal	51
Tabla 14. Asignación de Costos de Suministros de Limpieza, Servicio de lavado y Consumo Interno Lencería	52
Tabla 15. Asignación de Costos de Suministros de oficina y Suministros de operación.....	53
Tabla 16. Asignación de Costos de Gases Medicinales	54
Tabla 17. Asignación de Costos de Depreciación Edificio.....	55
Tabla 18. Asignación de Costos de Depreciación Muebles y Enseres	55
Tabla 19. Asignación de Costos de Depreciación Maquinaria y Equipo	56
Tabla 20. Asignación de Costos de Depreciación Equipo Médico y Depreciación Otros PPE	57
Tabla 21. Costos de las Actividades a los Servicios.....	59
Tabla 22. Costos totales de los servicios	60

Agradecimiento

Agradezco primeramente a Dios, a mi director de tesis CPA. Marco Leonardo Peralta Zúñiga quien con su conocimiento y experiencia ha logrado que podamos culminar este proyecto. Así mismo agradezco al Hospital San Juan de Dios, por la apertura ofrecida y la información brindada para la realización del trabajo de titulación. También gracias a cada una de las personas que fueron nuestro respaldo y con quienes compartimos gratos momentos en este largo camino. A la Universidad de Cuenca y a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que nos formaron a lo largo del camino de esta etapa de nuestras vidas.

Denisse Andrea Méndez Orellana

Agradezco a Dios por permitirme a llegar a culminar una fase muy importante en mi vida y concederme la sabiduría y la capacidad necesaria. Del mismo modo quiero agradecer a mis padres por brindarme todo su amor, sacrificio y recursos necesarios que me ayudaron a completar mis estudios universitarios. Así mismo agradezco al Hospital San Juan de Dios, quienes nos proporcionaron una amplia apertura en el desarrollo del proyecto con cordialidad y fraternidad. Por último, agradezco a nuestro tutor por brindarnos su guía, sus conocimientos y la dedicación necesaria en la elaboración del proyecto.

Camila Michelle Pallango Astudillo

Dedicatoria

Dedico primeramente a Dios y a mis padres Juan Méndez y Leonor Orellana quienes han sido un pilar fundamental y mi ejemplo a seguir, enseñándome que con dedicación y esfuerzo puedo alcanzar todo aquello que me proponga. A mis hermanas Vanessa y Verónica quienes siempre han estado presentes y me han otorgado consejos para seguir adelante. Así mismo a mis amigos por brindarme su apoyo y cariño en todo momento, acompañándome en esta etapa de mi vida y permitiendo que la universidad sea inolvidable.

Denisse Andrea Méndez Orellana

A Dios, quien es la razón y el propósito de mi vida, mi dador de fortaleza y guía. A María Santísima que por su amorosa intercesión logre culminar esta etapa. A mis padres Pablo y Guima, quienes han sido mis ángeles en el camino y me han otorgado todos mis valores y principios. A mis hermanos Andrés y Andrea que han sido una fuente de ejemplo, superación y esfuerzo. A mi familia y a mi pareja que me han brindado su cariño y apoyo incondicional durante todo este lapso. A todos ellos que son un pilar fundamental con la cual he podido alcanzar mis metas y superar todos los desafíos originados en esta cátedra.

Camila Michelle Pallango Astudillo

Introducción

El presente trabajo de titulación se centra en un análisis exhaustivo y sistemático del modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC) aplicado al Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios". El hospital a través de su estructura organizacional y servicios de atención médica especializada, busca ser un referente en temas relacionados con eficiencia y eficacia en la prestación de servicios hospitalarios. Sin embargo, carece de un sistema de costeo que le permita un correcto análisis de sus erogaciones monetarias, además sus procesos no se encuentran formalmente establecidos, pues las actividades se ejecutan de forma empírica, consecuentemente los costos son dirigidos a cuentas contables sin ningún tipo de supervisión, ni control. En la búsqueda de una mejor toma de decisiones y un manejo eficaz de los recursos, el estudio propone un análisis detallado de cómo la metodología ABC puede contribuir significativamente a la administración hospitalaria, específicamente en los procesos quirúrgicos (giro del negocio) a tener un control de los costos para una adecuada toma de decisiones.

En el Capítulo I, se presenta el contexto hospitalario destacando la infraestructura y capacidad instalada del "Hospital San Juan de Dios", se describe la dotación de servicios clínicos más representativos, como es el Área quirúrgica con sus principales procedimientos de desviación del tabique nasal, leiomioma del útero, parto único por cesárea, apendicitis aguda y colelitiasis, resaltando la importancia de contar con un sistema de costeo eficiente mediante el modelo planteado que con el análisis brindado permitirá categorizar los costos asociados a estos servicios.

El Capítulo II establece el marco conceptual del estudio, profundizando en los componentes y la relevancia de la contabilidad de costos. Se explora en detalle el sistema ABC como una evolución necesaria frente a los sistemas tradicionales de costeo, destacando la importancia de asignar costos de manera precisa basada en actividades reales. Se detallan los pasos críticos para la implementación del modelo, enfocándose en la identificación de actividades generadoras de costos, recursos vinculados e inductores de costos, así como en la cuantificación y asignación equitativa de costos indirectos. Además, se examinan las ventajas y desventajas del modelo, reconociendo los desafíos inherentes.

El Capítulo III aborda la implementación práctica del Sistema de Costos Basado en Actividades en el Área de Quirófano del Hospital San Juan de Dios. Se ofrece una visión descriptiva del espacio y su operación, detallando el proceso quirúrgico desde la preparación del paciente hasta la recuperación postoperatoria. Se identifica el proceso, actividades clave, recursos y costos directos e indirectos asociados, centrándose especialmente en la

asignación precisa de costos indirectos. La implementación del sistema incluye la identificación de inductores, la clasificación de costos relevantes y su distribución equitativa en función de las actividades realizadas.

El Capítulo IV concluye resaltando la efectividad del modelo ABC en la gestión hospitalaria, específicamente en el servicio de quirófano. Se destaca su flexibilidad y capacidad para proporcionar una asignación de costos más representativa, mejorando la comprensión de la distribución de costos y sirviendo como base para la toma de decisiones y el rendimiento empresarial. Se evidencia la relevancia del análisis de costos totales del servicio y la representatividad de la mano de obra directa en la estructura de costos, se señala la importancia de reflejar de manera precisa los costos indirectos. El capítulo formula, recomendaciones prácticas como la revisión constante de los costos y la expansión del costeo basado en actividades a otras áreas del hospital para lograr una eficiencia integral.

Justificación

ASOGALENICA S.A "Hospital San Juan de Dios" tiene 9 años de creación y vigencia en el mercado farmacéutico y hospitalario, dentro de su sector, se ubica entre las diez empresas que mayores ingresos generan en el Azuay. No obstante, a pesar de su tamaño y representatividad aún no cuenta con una metodología clara para la determinación de costos en sus servicios de hospitalización. Dichos servicios representan el 83% del total de los ingresos, que en promedio (considerando los últimos 3 años) ascienden a 3.500.000,00 USD. Adicionalmente, el hospital no cuenta con procesos debidamente levantados y formalizados, lo cual dificulta la erogación de recursos y su respectivo seguimiento. La alta dirección considera que se podría mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y eficacia a través de la aplicación de un sistema de costos que se ajusten a las necesidades del hospital.

Después de un análisis exhaustivo de la situación de la compañía y una revisión preliminar de los elementos del costo que podría englobar un servicio hospitalario, se llegó a la conclusión de que es prudente aplicar el Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC), por las siguientes razones (Duque y Osorio, 2003):

- El peso de los Costos Indirectos de Fabricación sobre el Total de Costos es representativo.
- El mercado es muy competitivo, los precios de los servicios están constantemente reduciéndose.
- Variedad de servicios que se ofrecen.

Los gastos operativos son estructurales y demandan de cambios estratégicos para cambiarlos.

Adicionalmente, se ha constatado que el hospital cumpla con las premisas del Sistema de Costos ABC, que son según Gosselin (2007):

- Los servicios demandan actividades para su ejecución.
- Las actividades exigen recursos para su realización.
- Los recursos demandan erogación monetaria para su consumo.

Por lo anteriormente mencionado, se ha conversado con el Gerente del hospital que el Sistema de Costos que se ajusta a sus necesidades es el Costeo Basado en Actividades (ABC), el cual ha sido aceptado y validado para su aplicación.

Planteamiento del Problema

ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios tiene como objeto social brindar todos los servicios relacionados con la salud en general y particularmente la prestación de servicios médico quirúrgicos y de especialidades, mediante facultativos especializados, previa calificación de su idoneidad y capacidad (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, 2023).

Actualmente la empresa ofrece diversos servicios hospitalarios dentro de las áreas del hospital como, por ejemplo: Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, Quirófano, Laboratorio, Imagenología, Farmacia, entre otros, mismas que desde hace unos años han venido creciendo y desarrollándose para constituirse en una de las empresas más grandes de la ciudad de Cuenca debido a su nivel de ingresos y personal capacitado, además de su competitividad y rentabilidad en el mercado.

Sin embargo, se ha tenido el conocimiento de que el Hospital a pesar de su tamaño y nivel de operaciones no cuenta con procesos formalizados relacionados a un sistema de costos interno que le permita determinar y administrar de manera eficiente los costos de la cartera de servicios que ofrece, de manera que se ha empleado como único recurso la experiencia y sin ningún análisis profundo, llevando a cabo una técnica empírica.

Al prestar el servicio se debe tomar en cuenta el requerimiento de diferentes equipos, instrumentos e insumos necesarios para poder establecer el precio al público. Es allí donde la problemática genera un impacto mayor, ya que los costos establecidos no reflejan el valor económico real de los egresos, y por ende no se tiene una apreciación verídica de las utilidades obtenidas.

Esta consecuencia desencadena en dificultades para la Gerencia en la toma de decisiones y el planteamiento de planes estratégicos enlazados directamente con la asignación de recursos y gestión de costos y gastos

Objetivos

Objetivos Generales

Determinar los costos de los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios a través del sistema de costeo basado en actividades (ABC) de manera que se proporcione una herramienta para el manejo eficiente y eficaz de los recursos.

Objetivos Específicos

1. Elaborar un análisis situacional de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.
2. Identificar los principales procesos llevados a cabo en el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.
3. Asignar los costos para cada actividad desarrollada en el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios a los objetos de costo mediante inductores.
4. Determinar los costos totales y unitarios para cada actividad dentro del área de Quirófano

Capítulo I

1.1 Aspectos Generales

1.1.1 *Reseña histórica de la organización*

El Hospital San Juan de Dios se originó con la intención de ofrecer servicios de salud eficaces y eficientes con un alto nivel de calidad, compromiso y responsabilidad social. En 2014, se constituyó ASOGALENICA, conocido como el Hospital San Juan de Dios, en el cual comenzó a brindar atención médica a la comunidad de Cuenca. Integran una unidad médica de segundo nivel con una amplia gama de servicios, con el propósito de proporcionar a la comunidad atención integral y especializada en salud, en un entorno cálido y eficiente, manteniendo altos estándares profesionales, formación continua y tecnología de vanguardia. Cuentan con un equipo de médicos de renombre en más de quince especialidades, centrados en mejorar la atención y la seguridad del paciente, con el objetivo de ofrecer una atención completa. Además, cuenta con una oferta de servicios extensa. En la actualidad, el Hospital San Juan de Dios se encuentra en un proceso de expansión y mejora; se ha implementado mejoras continuas para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios médicos, cumpliendo con estándares internacionales de calidad en el ámbito de la atención sanitaria (Hospital San Juan de Dios, 2022).

1.1.2 *Misión*

Brindar servicios de salud integral, especializada y complementaria, de segundo y tercer nivel de complejidad con una infraestructura y equipo médico con tecnología de vanguardia, profesionales capacitados y actualizados con amplio conocimiento científico y técnico, cumpliendo los programas de salud, apegados a los principios y valores de ética para proporcionar una atención oportuna con calidad, calidez, eficacia y eficiencia. (Hospital San Juan de Dios, 2022)

1.1.3 *Visión*

Posicionar al Hospital San Juan de Dios como uno de los mejores centros de atención de salud privada del Austro, con reconocimiento regional por su óptimo nivel de organización técnica, operativa y administrativa, brindando a sus colaboradores capacitación continua con un enfoque en la calidad para la prestación de servicios médicos y gestionando ante organismos competentes la certificación de excelencia. (Hospital San Juan de Dios, 2022)

1.1.4 Objetivos institucionales

Objetivo General. Convertir al Hospital en uno de los mejores centros de atención médica privada de la ciudad y referente a la provincia del Azuay, con personal altamente capacitado, óptima organización técnica, administrativa y operativa, equipos y tecnología de última generación, para funcionar como centro de referencia nacional en tratamientos de calidad y referente en la aplicación de estándares de calidad, eficiencia y eficacia. (Hospital San Juan de Dios, 2022)

Objetivos Específicos. Los objetivos específicos que guían a Hospital San Juan de Dios son (2022):

- “Alcanzar una rentabilidad igual a la media del mercado local.
- Incrementar la capacidad administrativa y de respuesta asistencial en base de las eficiencias en los procesos.
- Posicionar al Hospital San Juan de Dios entre los 5 primeros puestos de unidades asistenciales en la ciudad”.

1.1.5 Valores

Lealtad. “Asegurar el compromiso de la Institución con los colaboradores, conscientes de que son nuestro recurso más valioso, con el objetivo de crecer conjuntamente en un óptimo ambiente laboral” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Integridad. “Fomentar acciones éticas a los colaboradores del Hospital San Juan de Dios, de manera que su servicio garantice el bienestar de sus pacientes” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Justicia. “Mantener el relacionamiento institucional entre los cargos operativos, mandos medios y jerárquico superior de manera equitativa, con una política laboral, promocionando la justicia social y la promulgación, así como el seguimiento de las normas de trabajo a todo nivel” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Ética. “Actuar de acuerdo a los valores institucionales en todo momento y a todo nivel” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Respeto. “Brindar nuestros servicios con base a los conceptos de igualdad y equidad para atender las necesidades de las personas dignamente, teniendo en cuenta en todo momento sus derechos” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Lealtad. “Asegurar el compromiso de la Institución con los colaboradores, conscientes de que son nuestro recurso más valioso, con el objetivo de crecer conjuntamente en un óptimo ambiente laboral” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Integridad. “Fomentar acciones éticas a los colaboradores del Hospital San Juan de Dios, de manera que su servicio garantice el bienestar de sus pacientes” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Justicia. “Mantener el relacionamiento institucional entre los cargos operativos, mandos medios y jerárquico superior de manera equitativa, con una política laboral, promocionando la justicia social y la promulgación, así como el seguimiento de las normas de trabajo a todo nivel” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Ética. “Actuar de acuerdo a los valores institucionales en todo momento y a todo nivel” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Respeto. “Brindar nuestros servicios con base a los conceptos de igualdad y equidad para atender las necesidades de las personas dignamente, teniendo en cuenta en todo momento sus derechos” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Compromiso. “Involucrar a nuestros colaboradores tanto en su trabajo como en los objetivos y valores institucionales, desempeñándose con pasión en su trabajo y demostrando su mayor esfuerzo al realizar cada una de sus tareas y responsabilidades” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Vocación de servicio. “Realizar nuestra prestación de servicios con compromiso, pasión y espíritu de entrega” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Profesionalismo. “Actuar con responsabilidad, constancia, involucramiento, dedicación y esmero en cada función y tarea, buscando sumarse a la misión institucional” (Hospital San Juan de Dios, 2022).

1.2 Cartera de Servicios

1.2.1 Consulta Externa

La consulta externa sobresale gracias a su excepcional plantel de 95 especialistas, altamente competentes y comprometidos con la salud y el bienestar de sus pacientes. Cada experto cuenta con una extensa trayectoria en su respectiva disciplina y se dedica a brindar una atención médica a medida (Hospital San Juan de Dios, 2022).

1.2.2 Servicios Hospitalarios

Hospitalización. En la unidad de ingreso, disponen de un grupo de profesionales médicos y de enfermería altamente cualificados. Ofrecen habitaciones de diferentes tipos, que incluyen suites y habitaciones individuales, todas ellas están equipadas con sistemas de comunicación interna y teléfono privado, lo que facilita la comunicación inmediata y directa con el personal médico (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Emergencia. La sección de urgencias del Hospital San Juan de Dios (2022) proporciona atención continua durante las 24 horas, contando con un equipo de profesionales con diversas especialidades y subespecialidades. En esta zona, se encuentran disponibles:

- Espacio de evaluación inicial para adultos y niños.
- Compartimentos designados para las distintas especialidades y subespecialidades.

- Espacio destinado a situaciones críticas y un quirófano de emergencia para procedimientos ambulatorios.

Quirófano. Este espacio del Hospital San Juan de Dios (2022), está equipado con tecnología de vanguardia y un equipo médico de primer nivel que cumple con los estándares más exigentes en cuanto a calidad, garantizando la excelencia en cada procedimiento quirúrgico, tanto los generales como los laparoscópicos. Además, se asegura el cumplimiento de normativas rigurosas de higiene y esterilización. El servicio de cirugía se ve complementado por:

- Área para el nacimiento de bebés.
- Espacio para la recuperación después de cirugías.
- Lugar de acogida de recién nacidos.
- Centro de esterilización.

Unidad de cuidados intensivos. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está diseñada para el cuidado de pacientes en situaciones críticas o con condiciones médicas que requieren atención especializada y supervisión constante. Esta zona dispone de compartimentos equipados con ventiladores, monitores y un sistema central de suministro de gases médicos, además de una cámara de aislamiento con presión negativa destinada a tratar enfermedades infecciosas o situaciones de riesgo de contaminación (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Unidad de cuidados intensivos neonatales. La unidad de atención neonatal en cuidados intensivos se dedica al tratamiento de los recién nacidos que enfrentan situaciones de alto riesgo. Esta unidad está equipada con compartimentos para cuidados críticos e intermedios, así como con espacios de aislamiento y equipos médicos de última generación (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Servicios de Apoyo Diagnóstico. Los departamentos de diagnóstico de apoyo brindan un diagnóstico preventivo preciso como punto de partida para la recuperación de los pacientes. Llevan a cabo tareas como la realización de análisis clínicos y seguimiento de imágenes para todas las especialidades médicas, utilizando personal altamente capacitado y equipos de última generación. Para estas finalidades, cuentan con:

- Laboratorio clínico
- Ecografía 3D
- Radiología digital
- Exámenes oftalmológicos especiales
- TAC (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Laboratorio Clínico. Se ofrecen las siguientes prestaciones en el Hospital San Juan de Dios (2022):

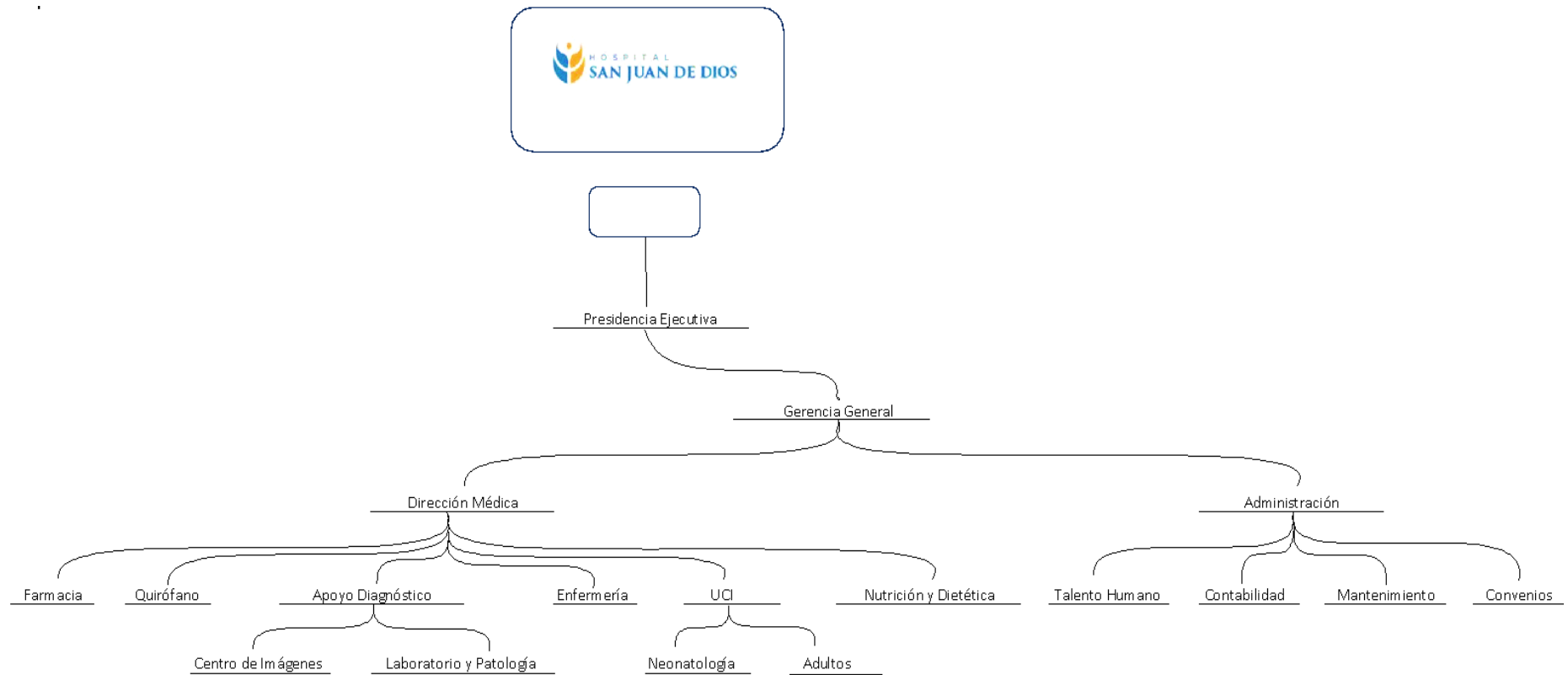
- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| • Hematología | • Coprología | • Hormonas |
| • Gasometrías | • Química | • Uroanálisis |
| • Panel toxicológico | sanguínea | • Microbiología |
| • Función renal | • Electrolitos | • Marcadores |
| • Prueba Covid | • Pruebas hepáticas | cardiacos |

Centro de Imágenes. El departamento de imágenes médicas cumple con las normativas nacionales e internacionales en cuanto a la seguridad biológica y las emisiones radiológicas, lo que garantiza la prestación de servicios de alto nivel de complejidad (Hospital San Juan de Dios, 2022).

Farmacia. Disponen de un extenso stock de fármacos y una amplia gama de suministros médicos y productos de higiene en su inventario. Además, ofrecen información detallada sobre los medicamentos mediante el uso del Vademécum Digital (Hospital San Juan de Dios, 2022).

1.3 Estructura organizacional de la empresa

Figura 1. Organigrama del Hospital San Juan de Dios



Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022)

Capítulo II

2.1 Marco Teórico

2.1.1 *Antecedentes de la investigación*

En la preparación del proyecto integrador, se han examinado diversos estudios e investigaciones que evidencian la relevancia, eficacia, viabilidad y repercusión del método de Costeo Basado en Actividades (ABC, por sus siglas en inglés: Activity Based Costing). El enfoque del modelo ABC se destaca por su capacidad para asignar y distribuir costos indirectos en función de las actividades llevadas a cabo, ya que son estas actividades las verdaderas generadoras de costos. Algunos de los principales trabajos académicos que han servido como antecedentes incluyen los siguientes:

Los autores Kaplan & Cooper (1999) del libro *Costo y efecto: uso de sistemas de costos integrados para impulsar la rentabilidad y el rendimiento* plantean que el modelo ABC se originó como una respuesta a las limitaciones percibidas en el sistema tradicional de contabilidad de costos.

En el sistema tradicional, los costos se asignaban de manera general, utilizando métodos como costos variables o costos fijos, lo que resultaba inadecuado para comprender completamente la relación entre los costos y las actividades reales en una organización. Los autores notaron que las empresas estaban experimentando importantes cambios en sus procesos y operaciones, con una creciente diversidad de productos y servicios, y una mayor complejidad en las actividades que respaldaban la producción y la prestación de servicios. Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos no podían capturar estas diferencias ni proporcionar información detallada sobre qué actividades consumían recursos y, por ende, generaban costos. Por lo tanto, el modelo ABC surgió como respuesta a la necesidad de las organizaciones de contar con una herramienta que representara con mayor precisión la estructura de costos en un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo.

Por otro lado, Horngren T et al. (2012), del libro *"Contabilidad de Costos un enfoque gerencial"* señala que el sistema ABC posibilita una asignación más precisa de los gastos a los productos, servicios o tareas, ya que se fundamenta en la identificación y seguimiento de las actividades específicas que utilizan recursos y conllevan costos.

Esto puede ofrecer una perspectiva más minuciosa de la estructura de gastos de una entidad, lo que habilita a los directivos a tomar decisiones mejor fundamentadas en lo que respecta a tarifas, reducción de costos y mejoras en la eficacia. El autor ha enfatizado la relevancia de

utilizar el ABC como una herramienta estratégica de gestión con el fin de optimizar la rentabilidad y el desempeño de la organización.

Bajo este último, es preciso señalar la metodología que el autor plantea:

- 3 Determinar cuáles son los productos que se han seleccionado como objetos de costos.
- 4 Reconocer los costos directos relacionados con dichos productos.
- 5 Elegir las actividades y las bases de aplicación de costos que se utilizarán para asignar los costos indirectos a los productos.
- 6 Identificar los costos indirectos asociados a cada base de aplicación de costos.
- 7 Establecer la tasa por unidad de cada base de aplicación de costos.
- 8 Calcular los costos indirectos asignados a los productos.
- 9 Determinar el costo total de los productos sumando todos los costos directos e indirectos asignados a los mismos.

Para Zapata Sánchez (2019), en el desarrollo del sistema de costeo ABC, es imprescindible conocer y comprender cada una de las fases que requieren su implementación y organización con las siguientes fases que se detallan a continuación:

Etapas Previas

- a) Evaluar la viabilidad y adecuación de la implementación del modelo ABC. Para ello, se llevará a cabo una evaluación para determinar lo siguiente:
 - Si los costos indirectos desempeñan un papel significativo en la estructura general de costos.
 - Si es posible realizar un seguimiento adecuado de los costos directos.
 - Si la empresa ofrece una amplia gama de servicios o si las líneas de servicio respaldan la adopción del modelo.
 - Si cuenta con un sistema informático capaz de integrar todos los componentes y recopilar los datos necesarios para alimentar la base de datos.
 - Evalúa el gasto financiero necesario tanto para la instauración inicial como para el sostenimiento continuado del sistema.
 - Analiza las ventajas competitivas que se obtendrían a corto y largo plazo como resultado de su implementación, es decir, además de considerar su viabilidad económica actual, mide el impacto que podría tener en el futuro.
- b) Definición del alcance del modelo ABC
 - Elegir los servicios empresariales que serán objeto de costeo a través del modelo
- c) Organización del equipo encargado del modelo ABC

- Definir niveles jerárquicos permitirá realizar un seguimiento efectivo y tomar decisiones adecuadas y oportunas.
- d) Proporcionar una formación adecuada a los empleados de la empresa sobre el modelo ABC y promover una comprensión general de sus beneficios para involucrar a los miembros de la organización.

Etapas de Implementación

A continuación, se detallan las fases requeridas para llevar a cabo la implementación y el mantenimiento del modelo ABC:

- a) Adquirir un conocimiento inicial de los procesos y la estructura de costos.
- b) Realizar una evaluación detallada de los procesos y actividades: Determinar quién realiza las tareas, cuánto se lleva a cabo y de qué manera se ejecutan las distintas actividades en la organización. Principalmente, se utilizan métodos como cuestionarios, encuestas, mediciones, observación, grabación de video, grabación de audio, etc.
- c) Seleccionar las actividades que serán objeto de costeo.
- d) Identificar los recursos invertidos: Identificar los costos y gastos que deben asignarse a los servicios finales.
- e) Asignar los recursos directos a los objetos de costo: Incluir estos elementos en los objetos de costo y convertirlos en costos directos.
- f) Asociar los recursos indirectos a las actividades: Se distinguen dos categorías de costos indirectos: comunes y específicos. Los costos comunes se distribuyen entre todas las actividades, mientras que los costos específicos se asignan a la actividad que los requirió y consumió.
- g) Transferir los costos de las actividades a los servicios finales: Esta transferencia puede lograrse identificando y empleando inductores o factores de costo.
- h) Cálculo de los costos totales.

Tomando en consideración a Robson-Vicens et al. (2021) en el contexto del costeo ABC, los recursos se asignan a las actividades, y luego, estas actividades incurren en costos que son transferidos a los productos. Por lo tanto, esta metodología enfatiza que son las actividades las responsables de incurrir en costos.

Así mismo, Rincón de Parra (2000) plantea una serie de pasos que llevan a la implementación del ABC.

1. Convicción del personal: Despertar el interés hacia esta metodología, superar obstáculos en su adopción y asegurar la aprobación de la alta dirección.
2. Desarrollar el plan de acción: Establecer metas, esbozar estrategias, definir el alcance, elegir miembros del equipo, brindar capacitación, establecer el presupuesto y planificar el cronograma del proyecto.
3. Recopilar información sobre los recursos (la cantidad mínima de insumos necesarios para llevar a cabo una actividad, expresado en términos monetarios), las actividades (conjunto de acciones destinadas a dar valor al proceso productivo) y los objetos de costos (la razón detrás de la realización de actividades, que requiere una medición independiente de costos).
4. Diseñar el modelo ABC: Identificar, detallar y analizar las actividades, así como identificar o determinar los inductores que inciden en los recursos y en las actividades.

Es decir, los costos de materiales directos se distribuyen según su consumo, y los costos de mano de obra directa se calculan en función de las horas laboradas. La distinción principal entre la asignación de costos mediante un sistema tradicional y el enfoque ABC radica en el proceso de asignación de los costos indirectos.

Adicional, es preciso describir las etapas o fases para distribuir los costos indirectos de fabricación, o carga fabril como usualmente se denominan según (Robson-Vicens et al. 2021).

Etapas I: Asignación de costos indirectos a las actividades

- a) Para esta etapa, se realizan tareas para su consecución
- b) Identificación, descripción y análisis de actividades: enumerar las diversas tareas realizadas, distinguiendo aquellas que tienen importancia suficiente para ser consideradas actividades, identificarlas de manera concisa y precisa al describir que hace esa actividad, y determinar cuáles de estas actividades aportan valor y cuáles no lo hacen.
- c) Agrupación de actividades homogéneas: aquellas actividades que comparten un proceso común y operan en el mismo nivel (ya sea en términos de unidad, lote, producto, instalación o prestación de servicio), lo que les permite emplear la misma estructura de costos para distribuir los costos a un objeto de costos.
- d) Determinación de los impulsores o inductores de costos de los recursos: los inductores, a veces denominados impulsores de costos, evalúan la necesidad de recursos para llevar a cabo una actividad y se emplean para asignar los costos de los recursos a esas actividades, manteniendo la relación causa-efecto adecuada entre el recurso, la actividad y el objeto de costos.

- e) Asignación de los costos (o recursos) a las diferentes actividades: usando los inductores de recursos previamente mencionados, identificados en c)

Etapas II: Asignación de costos de las actividades a los objetos de costos

Para la siguiente etapa se incluyen las siguientes subetapas:

- a) Determinación de los impulsores de actividades y cálculo del costo unitario de cada actividad: se emplean para distribuir los costos de las actividades hacia los objetos de costo, dividiendo los costos totales de cada actividad entre la cantidad de inductores asociados a cada actividad.
- b) Distribución de los costos de las actividades a los objetos de costos: una vez que se ha calculado el costo de cada actividad y se ha identificado el inductor de actividad en función de su vínculo con los objetos de costo, es posible determinar el uso que cada unidad de producto, servicio o línea de productos ha hecho de dichas actividades.

Pueden existir variaciones entre empresas que ofrecen diversos servicios. Sin embargo, la adopción del enfoque de costeo ABC en este contexto empresarial aporta valiosas ventajas.

Kaplan & Cooper (1999) sostienen que las compañías que se dedican a prestar servicios comparten aspectos de gestión similares a las empresas manufactureras, lo que justifica la necesidad de utilizar el costeo ABC para establecer una conexión entre los costos de los recursos y los ingresos generados por los servicios y los clientes que hacen uso de dichos recursos.

2.2 Marco Conceptual

2.2.1 Definición Costos

Los contadores describen el costo como la inversión de recursos destinada a alcanzar un objetivo concreto. Normalmente, un costo, como los materiales directos o los gastos en publicidad, se cuantifica en términos de la cantidad de dinero que se debe desembolsar para adquirir productos o servicios (Horngren T et al., 2012).

2.2.2 Contabilidad de Costos

Concepto. Para Lambretón Torres & Garza Fernández (2016), la contabilidad de costos se puede describir como la disciplina de la contabilidad que se dedica a categorizar, analizar, reunir, supervisar y asignar los gastos relacionados con los procesos, actividades o servicios para los cuales la empresa busca obtener mediciones separadas.

De igual manera Sánchez Barraza (2009) menciona que la contabilidad es aquella que se encarga de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos dirigido hacia un objeto de costo.

Importancia. La contabilidad de costos nos proporciona información relevante concerniente a los procesos propios de una organización. Al formar parte de un sistema general, como un subsistema, generalmente aplicado en empresas industriales, pero no exento para otros tipos de empresas, permite discernir cuál ha sido la inversión en la transformación de un producto. Sus criterios válidos pueden ser de aplicación para empresas de varios sectores de la economía como por ejemplo el sector agrícola, pecuarios, de alimentos, incluso puede determinar el costo de un servicio (Marulanda Castaño, 2009).

Mediante la información que brinda se puede comprender cuáles de los productos o servicios que ofrece la empresa son rentables, de esta manera puede gozar de una ventaja sobre la competencia en el mercado. Además, se considera que es importante ya que ayuda en una gestión suficiente y adecuada de los recursos y así evitar la sobreutilización de los mismos, convirtiéndose en una herramienta importante para la toma de decisiones de las empresas (Cuevas Villegas et al., 2004).

Objetivos. La contabilidad de costos tiene como objetivo tres puntos relevantes 1) Proporcionar información con el fin de evaluar las existencias. 2) Generar información que ayude en la planificación y control de control de las operaciones de la entidad. 3) Facilitar información sobre los costos para que la dirección tome decisiones informadas y estratégicas (Lazo Palacios, 2013).

Por otra parte, según Balanda (2005) los objetivos son la 1) Clasificación, tanto de productos o servicios a partir de conductas recurrentes, actividades y procesos en los cuales están vinculados. 2) Acumulación, por cuentas, trabajos, procesos u otras secciones. 3) Asignación de costos, a los distintos procesos o actividades que intervienen en la fabricación de un bien o servicios.

2.2.3 Elementos del Costo

Materia Prima. Comprendido como uno de los principales componentes, ya sea que se encuentren en su estado original o no, intervienen directamente en la producción de un bien o un servicio (Zapata Sánchez, 2015).

Mano de Obra. Considerada como la fuerza física o mental del ser humano, es empleada en la transformación de la materia prima, ya sea con ayuda de máquinas, equipos y tecnología (Zapata Sánchez, 2015).

Costos indirectos de fabricación. Son aquellos costos independientes que complementan a los procesos, pero no intervienen con los productos o servicios terminados (Zapata Sánchez, 2015).

2.2.4 Sistemas de Costeo

Costeo por procesos. Se trata de un sistema para registrar y acumular los costos de producción por área o centro de gasto. Un departamento se define como una unidad funcional clave en una planta de fabricación, y en ciertos casos, es útil subdividir el departamento en unidades más pequeñas llamadas centros de costos (Lazo Palacios, 2013).

Costeo por órdenes de producción. Este sistema es usado por empresas en donde se realizan procesos discontinuos, es decir que se realiza en intervalos de tiempo cierta cantidad de producto, ya sea por unidad, lote o cualquier acumulación de existencias (Lazo Palacios, 2013).

Costeo ABC. Se basa en desarrollar la acumulación de costos con base en las actividades que se efectúan dentro de los distintos procesos incurridos en una organización. Se refiere a una acumulación de costos más detallada que los anteriores sistemas mencionados, y además recientemente promovida por los creadores del Costeo Basado en Actividades (Cuervo Tafur et al., 2013).

2.2.5 Sistema de costos Basado en Actividades ABC

Concepto. Con base en Horngren T et al. (2012) la mejor forma de enriquecer un sistema de costos es implementando el costeo basado en actividades ya que este sistema se conceptualiza como la identificación de actividades, tareas o unidades de trabajo que poseen un objetivo en específico desarrolladas en una empresa, es decir de todas las funciones relativas a la cadena de valor, posterior asignan los costos al objeto referente o acumulativo de costos.

Objetivos. Según Zapata Sánchez (2015) los objetivos fundamentales del costeo basado en actividades son:

- Obtener datos precisos sobre los costos asociados a las actividades y procesos de la empresa, al mismo tiempo que se mejora la eficiencia en el uso de recursos y se alinea la organización con las demandas del mercado.
- Además, se busca que esta información funcione como un indicador de rendimiento que facilite la mejora de los objetivos de satisfacción y la reducción de residuos en las actividades operativas y administrativas.
- También se persigue que esta información sea empleada en la planificación empresarial, la determinación de ganancias, el control y la reducción de costos, y en la toma de decisiones estratégicas.
- En última instancia, el objetivo es integrar todos los datos necesarios para la gestión efectiva de la empresa, permitiendo que las organizaciones extiendan el control de costos para abarcar actividades intermedias, como la manufactura, las ventas, las finanzas y los procesos.

Como podemos ver este sistema tiene como finalidad proporcionar una visión más clara acerca de las actividades y buscar una mejora continua en cada una de ellas estableciendo costos más reales y detallados.

2.2.6 Definiciones básicas del modelo

Proceso. Un proceso se define como un conjunto de tareas laborales que están relacionadas entre sí, y se distinguen por la necesidad de ciertos elementos (insumos), que pueden ser productos o servicios provistos por otros, junto con actividades específicas que añaden valor con el propósito de alcanzar resultados determinados (Mallar, 2010).

Subproceso. Los subprocesos representan fragmentos más detallados de tareas que conforman actividades más amplias y funcionan como unidades de trabajo independientes dentro de un proceso más extenso. La evaluación de los subprocesos facilita una asignación más precisa de los costos al identificar cómo se emplean los recursos en actividades específicas, lo que a su vez contribuye a optimizar la toma de decisiones y la gestión de costos en la empresa (Horngren T et al., 2012).

Recursos. Los recursos son los medios utilizados para el desarrollo de las actividades, estos cumplen diversas funciones y características semejantes, así también se les asigna un valor adecuado garantizando un consumo fiable dentro de la organización. Para el Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC) los recursos van a depender del tamaño y a lo que se dedica la empresa, ya que de esta manera se podrá asignar e identificarlos oportunamente a cada actividad, y así los inductores destinarlos a su objeto de costos (Zapata Sánchez, 2015).

Actividad. Una actividad se define como una labor o procedimiento ejecutado con el propósito de alcanzar un objetivo específico. En el contexto del Sistema ABC, las actividades desempeñan un papel fundamental que requiere ser identificado, ya que proporcionan información esencial para la toma de decisiones. Es relevante subrayar que las actividades son componentes esenciales en el desarrollo de la secuencia de procesos de una organización, los cuales están orientados hacia la producción de bienes o la prestación de servicios. Las actividades también juegan un rol crucial en la determinación y asignación de los costos relacionados con estas operaciones (Horngren T et al., 2012).

Inductores. El "cost driver" o inductor de costos en el sistema ABC desempeña un papel esencial, ya que facilita una identificación más precisa de los factores y elementos que influyen en las actividades, incluyendo tanto criterios financieros como no financieros que resultan en la distribución de los costos indirectos en el producto o servicio (Zapata Sánchez, 2015).

Bajo este último, es preciso señalar que estos indicadores serán beneficiosos siempre y cuando cumplan tres aspectos importantes:

1. Que la información de los costos debe ser continua y que pueda ser comparable entre un año y otro.

2. La información debe ser pertinente, de manera que pueda responder oportunamente a los sucesos que se presenten en los inventarios.
3. Que sea cuantificable, ya que, con la generación de los datos proporcionados, se asignan los costos y se pueden hacer las distribuciones a cada actividad.

2.2.7 Ventajas y desventajas

Ventajas. Una de las virtudes que describe Calleja Bernal (2013) acerca del modelo ABC es la siguiente:

- La verificación y ajuste de los cálculos en las empresas se realiza con una base más equitativa y exacta, dado que los costos indirectos se distribuyen según su verdadero origen. En circunstancias excepcionales, el sistema confirma que la aplicación del costeo tradicional fue acertada.

En relación, Brito Laredo et al. (2010) describe como ventajas a las cuales se presentan a continuación:

- Pueden resultar en una administración más efectiva de los gastos y permitir una comprensión detallada de las actividades relacionadas con los costos, identificando cuáles de ellas demandan recursos.
- Puede servir como herramienta para la creación de una base de datos que contenga información que ayude en cuanto a implementación de procesos, control de calidad, que ayuden a evitar, o gestionar los problemas.
- Se puede implementar tanto en empresas de producción como en servicios.

Desventajas. Teniendo en cuenta a Renjifo (2013) las desventajas pueden ser comprendidas entre las siguientes:

- Pueden existir limitaciones con respecto al nivel de detalle que abarca. En ocasiones los detalles suelen llegar a ser excesivos y convertirse en innecesarios o contener datos pobres y dirigirlos al fracaso.
- Con la aparición de algún percance puede llegar a causar una tergiversación en la selección de las actividades y del sistema contable, y con esto interferir negativamente en los resultados.

- Es necesario un alto grado de juicio profesional en la aplicación del sistema ABC, debido a que no se puede aplicar aisladamente de otros modelos de gestión de costos y requiere de contemplaciones y mediciones precisas.

Al respecto Calleja Bernal (2013) expresa que la utilización de este enfoque de costeo en una dirección contraria se emplea en situaciones que resultan beneficiosas para la empresa, como es el caso de disqueras, editoriales, etc. En estas circunstancias, un producto de gran éxito se utiliza de manera deliberada para financiar otros productos que no alcanzan el mismo nivel de éxito.

2.3 Diseño Metodológico

2.3.1 Tipo de Investigación

Para la realización del trabajo de titulación se ha optado por aplicar un tipo de investigación descriptiva analítica con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Al referirnos al tipo de investigación descriptiva nos permitirá obtener un detalle pormenorizado de los costos relativos a las actividades desarrolladas en el Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, mediante la recolección, ordenación y análisis de datos, para alcanzar un conocimiento amplio y con ello poder establecer el modelo de Costeo Basado en Actividades ABC y generar un detalle sobre la aplicación del mismo. Con respecto al método analítico, podemos decir que nos posibilitará la comprensión y discernimiento de la información proporcionada por la administración y las áreas involucradas con las actividades que pertenecen al Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, de manera que nos permita relacionar y aplicar con el modelo de costo anteriormente mencionado.

2.3.2 Método de investigación

En cuanto al método de investigación que se va a llevar a cabo durante el trabajo de investigación será el método cuantitativo y cualitativo con referencia a un caso de estudio en ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios. Una de las características que comprende el método cuantitativo es la recolección de datos, los mismos que serán proporcionados por el sistema contable, la administración y las áreas involucradas con el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, posteriormente se procederá a la medición y análisis de los datos basado en el modelo planteado (Hernández Sampieri et al., 2014).

Por último, mediante el método cualitativo se plantea alcanzar conocimientos amplios acerca de la organización y en específico el área en cuestión, utilizando técnicas como entrevistas

abiertas, revisión de documentos, e interacción e introspección (Hernández Sampieri et al., 2014).

2.4 Metodología Utilizada para el Modelo ABC

Para llevar a cabo el presente proyecto integrador, se detalla a continuación los pasos que se aplicarán en la Capítulo III para la obtención de los costos por cirugía:

2.4.1 Levantamiento del proceso

Con referencia en Hernández Sampieri et al. (2014) se realizará una observación detallada y entrevistas al personal (Anexo D) acerca del proceso desarrollado en el área de modo que se identifiquen a los participantes involucrados en las actividades que abarcan desde sus ocupaciones laborales hasta momentos de esparcimiento, patrones de consumo, interacción con medios tecnológicos, etc. Esta descripción tiene como objetivo analizar cuándo y cómo llevan a cabo estas acciones, destacando los propósitos y funciones específicos de cada actividad.

Con base en Kaplan & Cooper (1999) se empleará el uso de instrumentos tales como diagramas de flujo (Anexo E) y fichas de procesos de validación (Anexo B) para registrar las actividades que han sido identificadas mediante visitas de observación con el fin de documentar las acciones llevadas a cabo en el Área de Quirófano.

2.4.2 Identificación y clasificación de las actividades

Con el objeto de realizar una identificación y clasificación de las actividades adecuada se procederá a diseñar un conjunto de preguntas abiertas para obtener información detallada sobre cada actividad que serán aplicadas en las visitas realizadas, teniendo en cuenta la relevancia de la interacción con el personal según como señala (Horngren T et al. 2012).

2.4.3 Identificación de los recursos invertidos

De conformidad con la etapa anterior se propone mediante las entrevistas (Anexo D) recopilar la información sobre los costos asociados a cada actividad.

Los costos de los recursos invertidos se obtendrán a través de sistema contable que maneja el hospital localizando los recursos con relación al Área de Quirófano.

2.4.4 Asignación de los recursos directos a los objetos de costo

Para el tratamiento de los costos de los recursos directos de acuerdo con Horngren T et al. (2012) se identificarán y separarán los costos variables directos, luego se definirán estándares mediante promedios para definir los costos directos y aplicarlos al modelo ABC dentro del costo de la prestación del servicio.

2.4.5 Determinación de inductores de costos de los recursos

Esta fase se establecerá mediante el criterio de Kaplan & Cooper (1999), ya que depende del tipo de actividad y su comportamiento, para ello plantea tres tipos:

- Relativo a la transacción: Cuando todos los recursos básicamente tienen las mismas exigencias de actividad.
- Relativo a la duración: indica la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo una actividad.
- Relativo a la intensidad: implica imputar directamente los recursos utilizados cada vez que se realiza una actividad.

En el caso de recursos determinados para diversas actividades o en concretas se direccionará mediante el lineamiento que propone Zapata Sánchez (2015) acerca de:

- Recursos específicos: Son aquellos claramente identificables con la actividad y que pueden asignarse de manera inequívoca a la misma.
- Recursos comunes: Son aquellos que son compartidos entre varias actividades, lo que hace difícil rastrearlos a una actividad específica.

2.4.6 Asociación de los recursos indirectos a las actividades

La relación de los recursos indirectos a las actividades según como se había descrito en líneas anteriores, teniendo en cuenta a Robson-Vicens et al. (2021) se planteará la distribución porcentual mediante el uso de los inductores de recursos previamente seleccionados.

2.4.7 Asignación de costos de las actividades a los Servicios (objetos de costos)

De acuerdo con Robson-Vicens et al. (2021) después de calcular el costo asociado con cada actividad se procederá a identificar el inductor de actividad según su relación con el objeto de costo, para ello se determinará la cantidad de procedimientos quirúrgicos de cada especialidad de servicio y seleccionar a las cirugías más significativas dentro del periodo, lo

que posibilitará mediante la distribución porcentual la asociación de dichas actividades a cada cirugía.

2.4.7 Cálculo de los costos totales

En función a lo expresado por Horngren T et al. (2012) en la etapa final se realizará la determinación del costo global de los procedimientos quirúrgicos a través de la suma de todos los costos directos e indirectos asignados a ellos.

Capítulo III

3.1. Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios"

En este capítulo se realiza una descripción general del Área de Quirófano del Hospital San Juan de Dios y sus elementos más representativos. Además, se explican los pasos descritos con anterioridad en la metodología seleccionada y como se adaptaron a la realidad del área de la organización objeto de estudio, es importante mencionar que el levantamiento, diseño y aplicación de la metodología se efectuó dentro del hospital.

3.2. Descripción del Área de Quirófano

El Área de Quirófano está compuesta por diversas salas, destacando la presencia de tres quirófanos equipados con todas las adecuaciones necesarias para ofrecer un servicio eficiente y eficaz en todas las especializaciones médicas proporcionadas por el hospital. Además, cuenta con una sala destinada a labores de parto y otra para la recuperación de pacientes. En esta área, se encuentra también un espacio central destinado a la esterilización, así como áreas específicas designadas para labores contaminadas. Además, se incluyen espacios como camerinos para médicos y enfermeras, lavaderos y dos cuartos de baño.

El proceso quirúrgico tiene como antesala el ingreso hospitalario, el mismo que consiste en la preparación del paciente, es decir, con la ropa adecuada y con la medicación de primera línea administrada según las indicaciones del médico. Posteriormente, se procede al ingreso al quirófano; en este espacio, una enfermera recibe al paciente, siendo la encargada de asistir durante todo el procedimiento quirúrgico. Su responsabilidad abarca desde suministrar los elementos necesarios, como guantes, pinzas y material instrumental, hasta atender las necesidades específicas del médico a cargo de la cirugía.

El equipo quirúrgico para las cirugías está conformado por el cirujano principal, el cirujano ayudante, una enfermera, el anestesiólogo y la circulante de enfermería. Es importante recalcar que el área de quirófano mantiene bajo rol a cuatro enfermeras, sin embargo, dos de ellas participan dentro del proceso quirúrgico.

Adicional se considera esencial establecer el número de cirugías que se realizaron durante el año 2022, las mismas que nos servirán para poder determinar varios de los cálculos correspondientes al modelo de costeo ABC, según como se muestra a continuación.

Tabla 1. Cirugías realizadas en el año 2022

Especialidad	Cirugías	Número De Cirugías
Ginecología	Parto Único por Cesárea	221
	Leiomioma del Útero	99
Otorrinolaringología	Desviación del Tabique Nasal	37
Cirugía General	Apendicitis Aguda	67
	Colelitiasis	137
Otras	Otras Cirugías	797
Total de Cirugías		1358

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

De acuerdo a la tabla 1, se observa las especialidades con sus respectivas cirugías y el número de cirugías que se han desarrollado en el año en cuestión, que serán el objeto de costo para las etapas posteriores de aplicación del sistema de costeo. Las cirugías indicadas fueron tomadas en consideración debido a su gran representatividad y a su relevancia para la organización, de modo que nos permitirá obtener una mejor determinación de los costos relacionados a estas cirugías por el volumen que en ellas se destacan.

Para una mejor visualización presentamos el siguiente gráfico que denota el volumen de cirugías efectuadas en el periodo 2022.

Figura 2. Cirugías realizadas en el año 2022

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

El mayor número de cirugías corresponde al Parto Único por Cesárea, seguido por la Colelitiasis, Leiomioma del Útero, Apendicitis Aguda, y la Desviación de Tabique Nasal. El gráfico también señala el volumen de Otras cirugías, pero no se destaca su relevancia debido a que refieren a procedimientos quirúrgicos que no son tan numerosos y por lo tanto no se conciben significativos para la aplicación del modelo de costos ABC.

3.3 Diseño del modelo ABC del área de Quirófano

3.3.1 Levantamiento del proceso

El análisis del proceso quirúrgico llevado a cabo en el hospital se basó en observación y entrevistas con los responsables del área de quirófano. Durante estas conversaciones, se resaltó que el único procedimiento llevado a cabo en esta área es el relacionado con las cirugías. Con el objetivo de presentar esta información de manera más clara, se ha elaborado un detallado diagrama de flujo, que se encuentra adjunto en el Anexo E.

El proceso de cirugía se considera como un conjunto de subprocesos y actividades diseñados con el propósito de realizar intervenciones en pacientes, ya sea para tratar enfermedades crónicas o abordar situaciones de emergencia.

3.3.2 Identificación y clasificación de las actividades

El total de actividades que se desarrollan para el procedimiento quirúrgico se han identificado y clasificado en subprocesos según como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Subprocesos y Actividades

Subproceso	Actividades
Recepción del Paciente	1. Recepción del paciente prequirúrgico 2. Verificación de datos del paciente 3. Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria
Valoración Pre Quirúrgica	4. Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo 5. Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo 6. Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano
Preparación del Quirófano	7. Preparación de equipos necesarios para la cirugía 8. Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano 9. Preparación del personal a intervenir en la cirugía
Intervención	10. Verificación de datos generales previo a la operación

	11	Intervención del anestesiólogo
	12	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico
	13	Realización de la cirugía programada
	14	Ingreso a la sala de post Operatorio
Recuperación	15	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.
	16	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.
	17	El paciente pasa a piso

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

La Tabla 2 muestra los subprocesos desarrollados agrupando un total de 17 actividades que han sido validadas y supervisadas por la organización mediante la observación directa y entrevistas efectuadas.

3.3.3 Identificación de los recursos invertidos

Es fundamental definir cuáles son los recursos empleados en la prestación del servicio específicamente en el proceso de cirugía. Para ello se contó con la disponibilidad y soporte del departamento de contabilidad y el sistema informático que maneja la organización, de esta forma se obtuvo el listado de costos y gastos reales y confiables generados en el periodo 2022.

Los recursos directos definidos en el proceso corresponden a los honorarios establecidos por los médicos cirujanos que intervienen en los procedimientos quirúrgicos, estos valores son aquellos que pueden identificarse directamente hacia el objeto de costo sin necesidad de asignación y se presentarán más adelante, pero cabe recalcar que han sido producto de una estandarización debido a que no son cantidades fijas y cambian según el galeno, por ende, se estableció un valor fijo que se explica en el Anexo F.

Con respecto a los recursos indirectos implicados en el proceso quirúrgico de igual forma se identificaron durante la etapa de levantamiento del proceso. A continuación, se presenta el detalle de los recursos indirectos que intervienen y sus costos.

Tabla 3. Recursos invertidos

Recursos	Costo
Costo de medicamentos e insumos	\$120,393.74
Arriendo Equipos	\$8,010.00
Mantenimiento Equipos Preventivo	\$19,629.31
Sueldos y Salarios	\$27,341.76

Horas extras	\$6,027.73
Bonos	\$2,082.90
Aportes patronales	\$4,324.52
Fondos de reserva	\$2,902.67
Décimo tercer sueldo personal	\$2,966.03
Décimo cuarto sueldo personal	\$1,912.68
Vacaciones del personal	\$1,544.49
Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	\$6,453.75
Mantenimientos varios	\$17.85
Mantenimiento de Edificio	\$244.01
Servicio de Agua Potable	\$362.48
Servicio de Energía Eléctrica	\$363.34
Servicio de Internet	\$218.77
Uniformes del personal	\$2,275.00
Suministros de Limpieza	\$579.02
Suministros de oficina	\$18.79
Servicio de lavado	\$6,583.04
Suministros de operación	\$325.69
Consumo Interno Lencería	\$1,369.20
Gases medicinales	\$36,096.69
Depreciación Edificio	\$9,289.61
Depreciación Muebles y Enseres	\$3,223.61
Depreciación Maquinaria y Equipo	\$31,035.03
Depreciación Equipo Médico	\$335.83
Depreciación Otros PPE	\$1,892.55

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

3.3.4 Asignación de los recursos directos a los objetos de costo

Los rubros por recursos directos identificados en la etapa anterior se incluyeron para convertirlos en costos directos. Es necesario aclarar que como servicio el hospital presta diferentes especialidades de cirugías que no tienen el mismo costo debido a su complejidad y tratamiento de los médicos cirujanos, por ende, los recursos que se presentan a continuación responden a cinco cirugías que son el enfoque del estudio en las etapas finales del sistema de costos ABC, y por ello es imprescindible contar estos recursos al iniciar esta etapa.

Tabla 4. Recursos directos

	Ginecología		Otorrinolaringología	Cirugía General	
Recursos Directos	Parto Único por Cesárea	Leiomioma del Útero	Desviación del Tabique Nasal	Apendicitis Aguda	Colelitiasis
MP	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MOD	\$1,055.85	\$1,361.77	\$1,810.22	\$942.50	\$870.38

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Como se puede observar en la Tabla 4, se encuentran identificados los procedimientos quirúrgicos y los recursos directos, con ello nos referimos a la materia prima y a la mano de obra directa. Al ser un servicio prestado a un paciente no se consideran costos por materia prima. Los costos por mano de obra directa indican costos unitarios establecidos a través del costo estándar.

3.3.5 Determinación de inductores de costos de los recursos

Para la asignación de los recursos indirectos a las actividades se procedió a definir inductores para recursos comunes y recursos específicos. A continuación, en la tabla 4 se muestran los inductores para los recursos comunes.

Tabla 5. Recursos Comunes y sus inductores

Recursos	Inductores
Costo de medicamentos e insumos	Porcentaje de requerimiento
Arriendo Equipos	Horas de utilización de máquinas en quirófano
Sueldos y Salarios	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Horas extras	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Bonos	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Aportes patronales	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Fondos de reserva	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Décimo tercer sueldo personal	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Décimo cuarto sueldo personal	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Vacaciones del personal	Horas de atención de enfermería en el área quirófano
Servicio de Agua Potable	Número de personas e instrumentos que intervienen en las actividades
Servicio de Energía Eléctrica	Cantidad de medida de kilovatios-hora que consume cada actividad
Gases medicinales	Horas de consumo de Gases medicinales en quirófano
Depreciación Muebles y Enseres	Representatividad del costo de muebles y enseres
Depreciación Maquinaria y Equipo	Representatividad del costo de máquina, equipo y tecnología

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

La Tabla 5 expone los recursos compartidos y los parámetros de asignación que desempeñan un papel en diversas etapas del proceso quirúrgico, e incluso en todas ellas.

Asimismo, en la Tabla 6 se detallan los inductores correspondientes a recursos específicos previamente definidos.

Tabla 6. Recurso Específico

Recursos	Parámetros
Mantenimiento Equipos Preventivo	Recurso Específico
Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	Recurso Específico
Mantenimientos varios	Recurso Específico
Mantenimiento de Edificio	Recurso Específico
Servicio de Internet	Recurso Específico
Uniformes del personal	Recurso Específico
Suministros de Limpieza	Recurso Específico
Suministros de oficina	Recurso Específico
Servicio de lavado	Recurso Específico
Suministros de operación	Recurso Específico
Consumo Interno Lencería	Recurso Específico
Depreciación Edificio	Recurso Específico
Depreciación Equipo Médico	Recurso Específico
Depreciación Otros PPE	Recurso Específico

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

La Tabla 6 presenta la relación entre los recursos específicos y sus respectivos inductores de asignación, los cuales ejercen influencia en una fase específica de las cirugías.

3.3.6 Asociación de los recursos indirectos a las actividades

Con la identificación de los recursos, su costo y clasificación, además de los inductores o parámetros de asignación, se procedió a distribuir los valores de los recursos hacia las actividades mediante los inductores indicados. A continuación, se visualiza la asignación por cada recurso.

- Costo de medicamentos e insumos**

El recurso referente al costo de medicamentos e insumos se asignó mediante el inductor de porcentaje de requerimiento necesario en ciertas actividades descritas en el levantamiento del proceso.

Tabla 7. Asignación de Costos de Medicamentos e Insumos

Recurso:			Costo de Medicamentos e Insumos	
Costo:			\$	120.393,74
Recepción del Paciente	1	0,18%	\$	221,80
	2	0,00%	\$	-
	3	0,00%	\$	-
Valoración Pre Quirúrgica	4	13,29%	\$	15.999,27
	5	0,00%	\$	-
	6	0,00%	\$	-

Preparación del Quirófano	7	0,00%	\$	-
	8	7,84%	\$	9.433,95
	9	9,70%	\$	11.681,54
Intervención	10	0,00%	\$	-
	11	7,55%	\$	9.093,86
	12	6,14%	\$	7.393,38
	13	42,20%	\$	50.807,28
Recuperación	14	13,09%	\$	15.762,67
	15	0,00%	\$	-
	16	0,00%	\$	-
	17	0,00%	\$	-
Totales		100,00%	\$	120.393,74

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

La Tabla 7 presenta las asignaciones correspondientes a las actividades que demandan los insumos y medicamentos esenciales para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico, empleando el parámetro establecido. El porcentaje se calculó considerando el costo de cada material en relación con el costo total de insumos y medicamentos. En el Anexo G, se encuentra disponible el listado estandarizado junto con sus respectivos costos para facilitar el cálculo preciso.

- **Arriendo de Equipos**

La asignación de los costos de arrendamiento de equipos se gestionó considerando el tiempo de utilización durante las fases de Preparación del Quirófano e Intervención. En otras palabras, se basó en el parámetro de Horas de utilización de máquinas en el quirófano, ya que es durante estas etapas que se destaca exclusivamente el funcionamiento de los equipos.

Tabla 8. Asignación de Costos de Arriendo de Equipos

Recurso:			Arriendo Equipos	
Costo:			\$	8.010,00
Recepción del Paciente	1	0,00%	\$	-
	2	0,00%	\$	-
	3	0,00%	\$	-
Valoración- Pre Quirúrgica	4	0,00%	\$	-
	5	0,00%	\$	-
	6	0,00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	6,00%	\$	480,60
	8	6,00%	\$	480,60
	9	6,00%	\$	480,60
Intervención	10	20,50%	\$	1.642,05
	11	20,50%	\$	1.642,05
	12	20,50%	\$	1.642,05
	13	20,50%	\$	1.642,05

	14	0,00%	\$	-
	15	0,00%	\$	-
Recuperación	16	0,00%	\$	-
	17	0,00%	\$	-
Totales		100,00%	\$	8.010,00

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 8, se pueden apreciar los recursos distribuidos proporcionalmente en las actividades asociadas a las etapas mencionadas. Para determinar el inductor, se tomaron en cuenta los tiempos de funcionamiento de los equipos en dichas etapas, como se detalla en el Anexo H. En cuanto al cálculo del indicador en cada actividad, se adoptó el criterio de distribución equitativa como una medida que se ajusta al uso de los equipos.

- **Mantenimientos**

El recurso vinculado a los mantenimientos abarca el Mantenimiento de equipos preventivo, Mantenimiento y reparaciones de equipos correctivos, Mantenimientos varios y Mantenimiento de Edificio. Estos fueron asignados como una categoría específica en la etapa de Recuperación. Esta elección se fundamenta en que los equipos reciben y se someten a los mantenimientos necesarios al concluir la fase de Intervención.

Tabla 9. Asignación de Costos de Mantenimiento

Recurso:			Mantenimiento Equipos Preventivo	Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	Mantenimientos varios	Mantenimiento de Edificio
Costo:			\$ 19.629,31	\$ 6.453,75	\$ 17,85	\$ 244,01
Recepción del Paciente	1	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	3	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valoración Pre Quirúrgica	4	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	5	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	6	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Preparación del Quirófano	7	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	8	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	9	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intervención	10	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	11	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	12	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	13	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recuperación	14	25,00%	\$ 4.907,33	\$ 1.613,44	\$ 4,46	\$ 61,00
	15	25,00%	\$ 4.907,33	\$ 1.613,44	\$ 4,46	\$ 61,00
	16	25,00%	\$ 4.907,33	\$ 1.613,44	\$ 4,46	\$ 61,00
	17	25,00%	\$ 4.907,33	\$ 1.613,44	\$ 4,46	\$ 61,00
Totales		100,00%	\$ 19.629,31	\$ 6.453,75	\$ 17,85	\$ 244,01

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Como se detalla en la Tabla 9, en la última etapa y en cada una de sus actividades, se asignaron los recursos de manera equitativa, siguiendo el enfoque mencionado anteriormente de manera apropiada con el significado del recurso.

- **Sueldos y salarios, Beneficios sociales y otros**

Tal como se había indicado previamente el costo del recurso correspondiente a sueldos y salarios, horas extras, bonos, aporte patronal, fondos de reserva, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones son aquellos valores pagados bajo rol a las enfermeras pertenecientes únicamente al área de quirófano. El inductor Horas de atención de enfermería en el área quirófano nos permitió prorratar apropiadamente los valores en las actividades que utilizan su tiempo.

Tabla 10. Asignación de Costos de Sueldos y salarios, Beneficios sociales y otros

Recurso:			Sueldos y Salarios	Horas extras	Bonos	Aportes patronales	Fondos de reserva	Décimo tercer sueldo personal	Décimo cuarto sueldo personal	Vacaciones del personal
Costo:			\$ 27,341.76	\$ 6,027.73	\$ 2,082.90	\$ 4,324.52	\$ 2,902.67	\$ 2,966.03	\$ 1,912.68	\$ 1,544.49
Recepción del Paciente	1	1.03%	\$ 280.43	\$ 61.82	\$ 21.36	\$ 44.35	\$ 29.77	\$ 30.42	\$ 19.62	\$ 15.84
	2	1.54%	\$ 420.64	\$ 92.73	\$ 32.04	\$ 66.53	\$ 44.66	\$ 45.63	\$ 29.43	\$ 23.76
	3	2.56%	\$ 701.07	\$ 154.56	\$ 53.41	\$ 110.89	\$ 74.43	\$ 76.05	\$ 49.04	\$ 39.60
Valoración Pre Quirúrgica	4	1.54%	\$ 420.64	\$ 92.73	\$ 32.04	\$ 66.53	\$ 44.66	\$ 45.63	\$ 29.43	\$ 23.76
	5	1.54%	\$ 420.64	\$ 92.73	\$ 32.04	\$ 66.53	\$ 44.66	\$ 45.63	\$ 29.43	\$ 23.76
	6	4.62%	\$ 1,261.93	\$ 278.20	\$ 96.13	\$ 199.59	\$ 133.97	\$ 136.89	\$ 88.28	\$ 71.28
Preparación del Quirófano	7	2.56%	\$ 701.07	\$ 154.56	\$ 53.41	\$ 110.89	\$ 74.43	\$ 76.05	\$ 49.04	\$ 39.60
	8	5.64%	\$ 1,542.36	\$ 340.03	\$ 117.50	\$ 243.95	\$ 163.74	\$ 167.31	\$ 107.89	\$ 87.13
	9	2.05%	\$ 560.86	\$ 123.65	\$ 42.73	\$ 88.71	\$ 59.54	\$ 60.84	\$ 39.23	\$ 31.68
Intervención	10	1.54%	\$ 420.64	\$ 92.73	\$ 32.04	\$ 66.53	\$ 44.66	\$ 45.63	\$ 29.43	\$ 23.76
	11	3.59%	\$ 981.50	\$ 216.38	\$ 74.77	\$ 155.24	\$ 104.20	\$ 106.47	\$ 68.66	\$ 55.44
	12	2.56%	\$ 701.07	\$ 154.56	\$ 53.41	\$ 110.89	\$ 74.43	\$ 76.05	\$ 49.04	\$ 39.60

	13	38.46%	\$ 10,516.06	\$ 2,318.36	\$ 801.12	\$ 1,663.28	\$ 1,116.41	\$ 1,140.78	\$ 735.65	\$ 594.03
	14	2.56%	\$ 701.07	\$ 154.56	\$ 53.41	\$ 110.89	\$ 74.43	\$ 76.05	\$ 49.04	\$ 39.60
	15	15.38%	\$ 4,206.42	\$ 927.34	\$ 320.45	\$ 665.31	\$ 446.56	\$ 456.31	\$ 294.26	\$ 237.61
Recuperación	16	2.56%	\$ 701.07	\$ 154.56	\$ 53.41	\$ 110.89	\$ 74.43	\$ 76.05	\$ 49.04	\$ 39.60
	17	10.26%	\$ 2,804.28	\$ 618.23	\$ 213.63	\$ 443.54	\$ 297.71	\$ 304.21	\$ 196.17	\$ 158.41
Totales		100.00%	\$ 27,341.76	\$ 6,027.73	\$ 2,082.90	\$ 4,324.52	\$ 2,902.67	\$ 2,966.03	\$ 1,912.68	\$ 1,544.49

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Conforme se aprecia en la Tabla 10, los costos de los recursos fueron asignados a la totalidad de las actividades del proceso, dado que las enfermeras participan en cada una de ellas. El inductor para cada actividad se determinó mediante un cálculo, donde el tiempo en minutos que cada enfermera dedica a realizar la actividad se dividió entre el total de minutos, tal como se detalla en el Anexo I. De esta manera, se asignó de forma sucesiva a cada costo de recurso del personal con la actividad correspondiente.

- **Servicio de Agua Potable**

Para calcular el costo del recurso de agua potable destinado al área de quirófano, se llevó a cabo mediante la consideración de los metros cuadrados que ocupa este espacio dentro de la sección de hospitalización, así como se detalla en el Anexo J.

La distribución de los costos asociados al servicio de agua potable se emprendió teniendo en cuenta tanto la cantidad de personas involucradas como la variedad de instrumentos utilizados en actividades específicas.

Tabla 11.Asignación de Costos de Servicio de Agua Potable

Recurso		Servicio de Agua Potable		
Costo		\$	362,48	
Recepción del Paciente	1	12.50%	\$	45,31
	2	0.00%	\$	-
	3	0.00%	\$	-
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$	-
	5	0.00%	\$	-
	6	0.00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	0.00%	\$	-
	8	0.00%	\$	-
	9	12.50%	\$	45,31
Intervención	10	0.00%	\$	-
	11	0.00%	\$	-
	12	0.00%	\$	-
	13	0.00%	\$	-
Recuperación	14	25.00%	\$	90,62
	15	0.00%	\$	-
	16	0.00%	\$	-
	17	50.00%	\$	181,24
Totales		100.00%	\$	362,48

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 11, se detallan los costos asociados al servicio de agua potable distribuidos entre las actividades correspondientes a las etapas identificadas. En el Anexo K, se presenta el porcentaje calculado, teniendo en cuenta tanto el número de personas como la variedad de instrumentos que utilizan el recurso en dichas actividades. Es importante destacar que, en la actividad número diecisiete dentro del subproceso de recuperación, se asignó directamente el 50% de los costos. Esto se debe a que en esta actividad específica se requiere un uso exhaustivo del servicio de agua potable para la esterilización de instrumentos esenciales durante intervenciones quirúrgicas.

- **Servicio de Energía Eléctrica**

De igual forma en el cálculo del costo de energía eléctrica destinado al área de quirófano, se llevó a cabo la determinación de los metros cuadrados que ocupa este espacio dentro de la sección de hospitalización, tal como se detalla en el Anexo J.

La asignación de los costos vinculados al servicio de energía eléctrica se realizó considerando la cantidad de kilovatios-hora consumidos en cada actividad. Esta elección se basa en la relación directa entre la energía eléctrica utilizada y la duración de cada actividad en el

quirófano. Cabe recalcar que ciertas actividades, tales como la etapa de intervención quirúrgica, consumen más energía debido al uso intensivo de equipos en esa área específica.

Tabla 12.Asignación de Costos de Servicio de Energía Eléctrica

Recurso		Servicio de Energía Eléctrica		
Costo		\$	363,34	
Recepción del Paciente	1	0.00%	\$	-
	2	0.00%	\$	-
	3	0.00%	\$	-
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$	-
	5	0.00%	\$	-
	6	0.00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	6.06%	\$	22,02
	8	6.06%	\$	22,02
	9	6.06%	\$	22,02
Intervención	10	20.46%	\$	74,32
	11	20.46%	\$	74,32
	12	20.46%	\$	74,32
	13	20.46%	\$	74,32
Recuperación	14	0.00%	\$	-
	15	0.00%	\$	-
	16	0.00%	\$	-
	17	0.00%	\$	-
Totales		100.00%	\$	363,34

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 12, se pueden apreciar los recursos distribuidos proporcionalmente en las actividades específicas. La distribución comienza en la etapa de preparación del quirófano debido a que en esta fase las máquinas se encienden para ser usadas en la etapa de intervención y para ello ya registran un consumo mínimo. Como se mencionó, el inductor referido a los kilovatios que consume cada máquina dentro del área de quirófano se presenta dentro del Anexo L. Posterior, dentro del Anexo M se expone a detalle el consumo requerido en cada etapa o subproceso. En cuanto al cálculo de asignación en cada actividad, se adoptó el criterio de distribución equitativa como una medida que se ajusta al uso y tiempo de los equipos y la cantidad de energía consumida ($\text{Consumo} = \text{kilovatios} \times \text{tiempo}$).

- **Servicio de Internet y Uniformes personal**

En relación con el costo del servicio de internet destinado al área de quirófano, se empleó una vez más el cálculo de los metros cuadrados que ocupa este espacio dentro de la sección de hospitalización, según como se detalla en el Anexo J. De igual manera los uniformes del personal constituyen a aquellos concernientes al área.

Tabla 13. Asignación de Costos de Servicio de Internet y Uniformes del personal

Recurso		Servicio de Internet		Uniformes del personal	
Costo		\$	218,77	\$	2.275,00
Recepción del Paciente	1	\$	12,87	\$	133,82
	2	\$	12,87	\$	133,82
	3	\$	12,87	\$	133,82
Valoración Pre-Quirúrgica	4	\$	12,87	\$	133,82
	5	\$	12,87	\$	133,82
	6	\$	12,87	\$	133,82
Preparación del Quirófano	7	\$	12,87	\$	133,82
	8	\$	12,87	\$	133,82
	9	\$	12,87	\$	133,82
Intervención	10	\$	12,87	\$	133,82
	11	\$	12,87	\$	133,82
	12	\$	12,87	\$	133,82
	13	\$	12,87	\$	133,82
Recuperación	14	\$	12,87	\$	133,82
	15	\$	12,87	\$	133,82
	16	\$	12,87	\$	133,82
	17	\$	12,87	\$	133,82
Totales		\$	218,77	\$	2.275,00

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 13, tanto el Servicio de Internet como los Uniformes del personal son tratados como costos indirectos que aportan beneficios y son utilizados en las todas actividades desarrolladas en especial a los uniformes del personal puesto que las enfermeras destinan el uso de sus uniformes desde el momento en el que ingresan al área estéril. Estos costos se asignan de manera equitativa a todas las actividades.

- **Suministros de Limpieza, Servicio de lavado y Consumo Interno Lencería**

El recurso asociado a los Suministros de Limpieza, Servicio de Lavado y Consumo Interno de Lencería se asignó como una categoría específica durante la etapa de Recuperación. Esta decisión se basa en la importancia de la limpieza, el lavado, y la esterilización de la lencería

dado que son elementos esenciales después de concluir la fase de Intervención, por ello se establece la vinculación directa a una etapa específica dentro del proceso.

Tabla 14. Asignación de Costos de Suministros de Limpieza, Servicio de lavado y Consumo Interno Lencería

Recurso			Suministros de Limpieza	Servicio de lavado	Consumo Interno Lencería
Costo			\$ 579,02	\$ 6.583,04	\$ 1.369,20
Recepción del Paciente	1	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	2	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	3	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	5	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	6	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
Preparación del Quirófano	7	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	8	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	9	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
Intervención	10	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	11	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	12	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
	13	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
Recuperación	14	25.00%	\$ 144,76	\$ 1.645,76	\$ 342,30
	15	25.00%	\$ 144,76	\$ 1.645,76	\$ 342,30
	16	25.00%	\$ 144,76	\$ 1.645,76	\$ 342,30
	17	25.00%	\$ 144,76	\$ 1.645,76	\$ 342,30
Totales			\$ 579,02	\$ 6.583,04	\$ 1.369,20
100.00%					

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Como se observa en la Tabla 14, durante la fase final, en todas sus actividades, los recursos se asignaron en partes iguales, debido a que el consumo del recurso se realiza indistintamente y se vuelve imprescindible un prorrateo ecuánime.

- **Suministros de oficina y Suministros de operación**

A cerca de los Suministros de oficina y Suministros de operación, la distribución se efectuó como una categoría específica puesto que se relacionan directamente a ciertas actividades dentro del área quirófano.

Tabla 15. Asignación de Costos de Suministros de oficina y Suministros de operación

Recurso		Suministros de oficina		Suministros de operación	
Costo		\$	18,79	\$	325,69
Recepción del Paciente	1	\$	-	\$	-
	2	\$	6,26	\$	-
	3	\$	6,26	\$	-
Valoración Pre-Quirúrgica	4	\$	6,26	\$	-
	5	\$	-	\$	-
	6	\$	-	\$	-
Preparación del Quirófano	7	\$	-	\$	-
	8	\$	-	\$	54,28
	9	\$	-	\$	54,28
Intervención	10	\$	-	\$	54,28
	11	\$	-	\$	54,28
	12	\$	-	\$	54,28
	13	\$	-	\$	54,28
Recuperación	14	\$	-	\$	-
	15	\$	-	\$	-
	16	\$	-	\$	-
	17	\$	-	\$	-
Totales		\$	18,79	\$	325,69

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

De acuerdo a la Tabla 15, se visualiza los recursos distribuidos de manera equitativa siguiendo el enfoque mencionado en cada una de las actividades que consumen los suministros. En el caso de los suministros de oficina, el consumo es requerido específicamente en las actividades en las cuales se realiza una verificación de los datos del paciente. Por otro lado, los suministros de operación se refieren instrumentos ocasionales necesarios para la etapa de preparación e intervención. Este método de distribución se implementó con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y justa de los recursos en el marco de las actividades específicas señaladas en la tabla.

- **Gases Medicinales**

La asignación de los costos se llevó a cabo considerando las Horas de Consumo de Gases Medicinales en el quirófano, ya que el inductor proporciona una medida relevante y lógica para la distribución de costos en el contexto específico del área quirúrgica. Cabe destacar que la etapa de intervención quirúrgica, genera un mayor consumo debido al uso intensivo de gases medicinales durante la operación del paciente. Este enfoque garantiza una asignación precisa

y proporcional de los costos asociados con el suministro de gases medicinales en cada actividad quirúrgica en las que se utilicen.

Tabla 16. Asignación de Costos de Gases Medicinales

Recurso		Gases medicinales		
Costo		\$	36.096,69	
Recepción del Paciente	1	0.00%	\$	-
	2	0.00%	\$	-
	3	0.00%	\$	-
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$	-
	5	0.00%	\$	-
	6	0.00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	6.00%	\$	2.165,80
	8	6.00%	\$	2.165,80
	9	6.00%	\$	2.165,80
Intervención	10	20.50%	\$	7.399,82
	11	20.50%	\$	7.399,82
	12	20.50%	\$	7.399,82
	13	20.50%	\$	7.399,82
Recuperación	14	0.00%	\$	-
	15	0.00%	\$	-
	16	0.00%	\$	-
	17	0.00%	\$	-
Totales		100.00%	\$	36.096,69

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 16, se presentan detalladamente los costos asociados a los gases medicinales, distribuidos entre las actividades vinculadas a la etapa de preparación e intervención porque desde la actividad número siete el consumo es necesario. Para determinar el inductor, se consideraron los tiempos específicos en estas etapas, tal como se describe en el Anexo N. En relación al cálculo del indicador para cada actividad, se optó por el criterio de distribución equitativa, una medida que se adecua de manera proporcionada al uso de los gases medicinales.

- **Depreciaciones**

El recurso vinculado a las depreciaciones constituye la Depreciación de Edificio, Depreciación Muebles y Enseres, Depreciación Maquinaria y Equipo, Depreciación Equipo Médico, Depreciación Otros PPE.

Tabla 17. Asignación de Costos de Depreciación Edificio

Recurso		Depreciación Edificio	
Costo		\$	9.289,61
Recepción del Paciente	1	\$	546,45
	2	\$	546,45
	3	\$	546,45
Valoración Pre-Quirúrgica	4	\$	546,45
	5	\$	546,45
	6	\$	546,45
Preparación del Quirófano	7	\$	546,45
	8	\$	546,45
	9	\$	546,45
Intervención	10	\$	546,45
	11	\$	546,45
	12	\$	546,45
	13	\$	546,45
Recuperación	14	\$	546,45
	15	\$	546,45
	16	\$	546,45
	17	\$	546,45
Totales		\$	9.289,61

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Para calcular el costo del recurso de depreciación del edificio destinado al área de quirófano, de igual manera se consideró el uso del cálculo de los metros cuadrados que ocupa este espacio dentro de la sección de hospitalización, como se detalla en el Anexo J.

Conforme se especifica en la Tabla 17, la depreciación del edificio, al ser un costo indirecto asociado al aprovechamiento del espacio para la realización de diversas actividades, se asigna de manera proporcional a todas las actividades, considerando su respectiva contribución al desgaste y uso del edificio.

Tabla 18. Asignación de Costos de Depreciación Muebles y Enseres

Recurso		Depreciación Muebles y Enseres	
Costo		\$	3.223,61

Recepción del Paciente	1	0.10%	\$	3,07
	2	0.10%	\$	3,07
	3	0.10%	\$	3,07
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$	-
	5	0.00%	\$	-
	6	0.00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	1.93%	\$	62,21
	8	1.93%	\$	62,21
	9	1.93%	\$	62,21
Intervención	10	10.87%	\$	350,46
	11	10.87%	\$	350,46
	12	10.87%	\$	350,46
	13	10.87%	\$	350,46
Recuperación	14	12.61%	\$	406,48
	15	12.61%	\$	406,48
	16	12.61%	\$	406,48
	17	12.61%	\$	406,48
Totales		100.00%	\$	3.223,61

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la Tabla 18, se presentan los recursos distribuidos de manera proporcional entre las distintas actividades. El cálculo porcentual se fundamentó en la representatividad del costo de cada mueble y enser, con respecto al costo total de muebles y enseres del área. Los cálculos se pueden encontrar dentro del Anexo Ñ donde se establece el criterio de distribución equitativa.

Tabla 19. Asignación de Costos de Depreciación Maquinaria y Equipo

Recurso		Depreciación Maquinaria y Equipo		
Costo		\$	31.035,03	
Recepción del Paciente	1	0.00%	\$	-
	2	0.00%	\$	-
	3	0.00%	\$	-
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$	-
	5	0.00%	\$	-
	6	0.00%	\$	-
Preparación del Quirófano	7	6.67%	\$	2.069,00
	8	6.67%	\$	2.069,00
	9	6.67%	\$	2.069,00
Intervención	10	20.00%	\$	6.207,01
	11	20.00%	\$	6.207,01
	12	20.00%	\$	6.207,01
	13	20.00%	\$	6.207,01

	14	0.00%	\$	-
Recuperación	15	0.00%	\$	-
	16	0.00%	\$	-
	17	0.00%	\$	-
Totales		100.00%	\$	31.035,03

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Tal como se puede observar en la Tabla 19, los recursos concernientes a la Depreciación de Maquinaria y Equipo se asignan a mediante el prorrateo a las actividades de la etapa de preparación e intervención dado que el consumo y desgaste de estos bienes se da únicamente dentro de estas actividades. La forma de distribución se basó en la representatividad del costo de máquina, equipo y tecnología, considerando el costo de cada bien en razón del costo global de este grupo de activos del área. En el cálculo del indicador para cada actividad, se aplicó el criterio de distribución equitativa, tal como se detalla en el Anexo O.

Tabla 20. Asignación de Costos de Depreciación Equipo Médico y Depreciación Otros PPE

Recurso			Depreciación Equipo Médico	Depreciación Otros PPE
Costo			\$ 335,83	\$ 1.892,55
Recepción del Paciente	1	0.00%	\$ -	\$ -
	2	0.00%	\$ -	\$ -
	3	0.00%	\$ -	\$ -
Valoración Pre-Quirúrgica	4	0.00%	\$ -	\$ -
	5	0.00%	\$ -	\$ -
	6	0.00%	\$ -	\$ -
Preparación del Quirófano	7	0.00%	\$ -	\$ -
	8	0.00%	\$ -	\$ -
	9	0.00%	\$ -	\$ -
Intervención	10	25.00%	\$ 83,96	\$ 473,14
	11	25.00%	\$ 83,96	\$ 473,14
	12	25.00%	\$ 83,96	\$ 473,14
	13	25.00%	\$ 83,96	\$ 473,14
Recuperación	14	0.00%	\$ -	\$ -
	15	0.00%	\$ -	\$ -
	16	0.00%	\$ -	\$ -
	17	0.00%	\$ -	\$ -
Totales			\$ 335,83	\$ 1.892,55

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En cuanto a la Tabla 20, se detalla la distribución de recursos en la fase de intervención y sus respectivas actividades por el hecho de que son bienes referidos a instrumentos médicos

utilizados únicamente dentro de esta etapa. Se proporciona una perspectiva detallada sobre cómo se asignan los costos de depreciación en las actividades de intervención médica, indicando que la asignación porcentual por partes iguales facilita la contribución real de los costos totales relacionados con los recursos mencionados.

3.3.7 Asignación de costos de las actividades a los Servicios (objetos de costos)

A continuación, se detallan los costos totales de cada actividad, los cuales fueron asignados a cada uno de los servicios finales.

Tabla 21. Costos de las Actividades a los Servicios

Asignación del Costo por Actividad a los Servicios											
		Ginecología		ORL		Cirugía General		Otras Cirugías	Totales	Inductor	
		Parto Único por Cesárea	Leiomioma del Útero	Desviación del Tabique Nasal	Apendicitis Aguda	Colelitiasis					
		221 16.27%	99 7.29%	37 2.72%	67 4.93%	137 10.09%		797 58.69%	1358 100%		
Ingresos del Paciente	1	\$ 1,467.08	\$ 238.75	\$ 106.95	\$ 39.97	\$ 72.38	\$ 148.00	\$ 861.02	\$ 1,467.08	N°CirugíasRealizadas	
	2	\$ 1,457.92	\$ 237.26	\$ 106.28	\$ 39.72	\$ 71.93	\$ 147.08	\$ 855.64	\$ 1,457.92	N°CirugíasRealizadas	
	3	\$ 1,961.55	\$ 319.22	\$ 143.00	\$ 53.44	\$ 96.78	\$ 197.89	\$ 1,151.22	\$ 1,961.55	N°CirugíasRealizadas	
Valoración Pre Quirúrgica	4	\$ 17,454.25	\$ 2,840.49	\$ 1,272.44	\$ 475.56	\$ 861.14	\$ 1,760.85	\$ 10,243.77	\$ 17,454.25	N°CirugíasRealizadas	
	5	\$ 1,448.58	\$ 235.74	\$ 105.60	\$ 9.47	\$ 71.47	\$ 146.14	\$ 850.16	\$ 1,448.58	N°CirugíasRealizadas	
	6	\$ 2,959.47	\$ 481.62	\$ 215.75	\$ 80.63	\$ 146.01	\$ 298.56	\$ 1,736.89	\$ 2,959.47	N°CirugíasRealizadas	
Preparación del Quirófano	7	\$ 6,752.11	\$ 1,098.83	\$ 492.24	\$ 183.97	\$ 333.13	\$ 681.18	\$ 3,962.76	\$ 6,752.11	N°CirugíasRealizadas	
	8	\$ 17,751.30	\$ 2,888.83	\$ 1,294.09	\$ 483.65	\$ 875.80	\$ 1,790.82	\$ 10,418.10	\$ 17,751.30	N°CirugíasRealizadas	
	9	\$ 18,281.65	\$ 2,975.14	\$ 1,332.76	\$ 498.10	\$ 901.97	\$ 1,844.32	\$ 10,729.36	\$ 18,281.65	N°CirugíasRealizadas	
Intervención	10	\$ 17,735.05	\$ 2,886.19	\$ 1,292.91	\$ 483.21	\$ 875.00	\$ 1,789.18	\$ 10,408.57	\$ 17,735.05	N°CirugíasRealizadas	
	11	\$ 27,836.24	\$ 4,530.05	\$ 2,029.30	\$ 758.42	\$ 1,373.36	\$ 2,808.22	\$ 16,336.88	\$ 27,836.24	N°CirugíasRealizadas	
	12	\$ 25,632.12	\$ 4,171.35	\$ 1,868.62	\$ 698.37	\$ 1,264.62	\$ 2,585.86	\$ 15,043.30	\$ 25,632.12	N°CirugíasRealizadas	
	13	\$ 86,673.37	\$ 14,105.17	\$ 6,318.60	\$ 2,361.50	\$ 4,276.23	\$ 8,743.93	\$ 50,867.95	\$ 86,673.37	N°CirugíasRealizadas	
Recuperación	14	\$ 26,932.78	\$ 4,383.02	\$ 1,963.44	\$ 733.81	\$ 1,328.79	\$ 2,717.08	\$ 15,806.65	\$ 26,932.78	N°CirugíasRealizadas	
	15	\$ 17,374.46	\$ 2,827.51	\$ 1,266.62	\$ 473.38	\$ 857.21	\$ 1,752.80	\$ 0,196.94	\$ 17,374.46	N°CirugíasRealizadas	
	16	\$ 11,079.11	\$ 1,803.01	\$ 807.68	\$ 301.86	\$ 546.61	\$ 1,117.70	\$ 6,502.25	\$ 11,079.11	N°CirugíasRealizadas	
	17	\$ 15,038.06	\$ 2,447.28	\$ 1,096.29	\$ 409.73	\$ 741.94	\$ 1,517.09	\$ 8,825.73	\$ 15,038.06	N°CirugíasRealizadas	
Total Rubros de Actividades		\$ 297,835.09	\$ 48,469.48	\$ 21,712.57	\$ 8,114.80	\$ 14,694.37	\$ 30,046.69	\$ 174,797.18	\$ 297,835.09		

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

Una vez que hemos calculado los costos totales de las actividades, procedemos a distribuirlos entre los servicios. Para esta asignación, hemos elegido el número de cirugías realizadas durante el periodo 2022 como inductor. Esta selección se fundamenta en su eficacia para asignar costos en los servicios quirúrgicos, dado su vínculo directo con la actividad principal, su proporcionalidad real en el consumo de recursos y su idoneidad en los procedimientos.

En la tabla 21, se detallan los porcentajes de distribución que se calcularon dividiendo el número de cirugías específicas entre el total de cirugías realizadas. En el caso de las cesáreas por parto único, se llevaron a cabo 221 cirugías, lo que representa un 16.27% del total de 1358 cirugías realizadas en el año 2022 siendo este el procedimiento quirúrgico más numeroso del periodo. Este proceso se replicó para cada uno de los servicios finales con el fin de obtener el porcentaje de distribución correspondiente.

3.3.8 Cálculo de los costos totales

A continuación, se presentan los costos totales de los objetos de costo o también denominados servicios finales divididos por cada especialidad.

Tabla 22. Costos totales de los servicios

	Ginecología		ORL	Cirugía General	
	Parto Único por Cesárea	Leiomioma del Útero	Desviación del Tabique Nasal	Apendicitis Aguda	Colelitiasis
Materia Prima	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mano de Obra Directa	\$ 233,342.85	\$ 135,175.59	\$ 75,620.60	\$ 63,004.12	\$ 119,242.06
CIF	\$ 48,469.48	\$ 21,712.57	\$ 8,114.80	\$ 14,694.37	\$ 30,046.69
Total Costo del Servicio	\$ 281,812.33	\$ 156,888.16	\$ 83,735.40	\$ 77,698.49	\$ 149,288.75
Costo Unitario	\$ 1,275.17	\$ 1,584.73	\$ 2,263.12	\$ 1,159.68	\$ 1,089.70

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Hospital San Juan de Dios (2022).

En la columna izquierda se exhiben los elementos que componen el costo total de cada cirugía. En cuanto a la materia prima, como se mencionó anteriormente, el servicio no posee valores directamente identificables como materia prima, lo que resulta en la ausencia de valor para todos los procedimientos quirúrgicos. En relación con la mano de obra directa, los costos directos ya se establecieron previamente en la Tabla 4; sin embargo, es necesario determinar valores anuales para lograr uniformidad con los demás rubros.

Los costos indirectos de fabricación (CIF) presentados son el resultado de la etapa anterior y se exponen de manera similar para cada servicio final. La suma de estos tres elementos del costo proporciona el total del Costo del Servicio para cada cirugía.

Finalmente, el costo unitario se obtiene dividiendo el total del Costo del Servicio entre el número de procedimientos quirúrgicos específicos realizados durante el periodo 2022 para cada cirugía.

Conclusiones

La aplicación del modelo de Costos Basado en Actividades posibilitó el manejo de una herramienta útil y eficaz con la capacidad de gestionar actividades mediante una asignación precisa de los costos, de manera que se obtuvo una distribución de acuerdo a las necesidades expuestas en cada actividad ejecutada en el proceso de una cirugía. La aplicación del modelo resultó exitosa debido a su flexibilidad y adaptabilidad en los servicios hospitalarios dentro del Área de Quirófano, pues se pudo evidenciar a lo largo de la investigación con toda la información y los recursos reales involucrados que fueron recolectados en las instalaciones del hospital que como se mencionó anteriormente, carece de un sistema de costeo y, por ende, no cuenta con un mecanismo de control, por lo que los costos se registraban únicamente en cuentas contables sin supervisión, ni control. Un punto relevante que supone al modelo ser el más idóneo para costear los servicios quirúrgicos, es acerca de la asignación de costos indirectos de fabricación, ya que al tener un rastreo complejo o no poderlos asignar de manera directa se demuestra que la asignación con enfoque en actividades es la mejor alternativa para la empresa, pues tiene un peso representativo en el total del costo.

Para poder aprovechar todo el potencial y particularidades del modelo fue importante definir y aplicar de forma adecuada todos los pasos que se expone en su metodología dentro del Capítulo 2, para ello se realizó un levantamiento del proceso ya que no existía un protocolo formalmente establecido, sin embargo se pudo encontrar que la programación de las cirugías se llevaban a cabo de forma regular, la dotación de insumos contaba con la debida anticipación, la comunicación dentro del área e interdepartamental se cubría constantemente, se revisaban los protocolos de seguridad desde la preparación preoperatoria hasta la salida del paciente y existía una apropiada gestión de equipos y tecnología con retroalimentación del personal. Seguido de esta etapa, se efectuó la identificación y clasificación de subprocesos y actividades, conocimiento de todos los elementos y factores involucrados en el área para poder determinar los recursos invertidos, el cual permitió comprender mejor la estructura del procedimiento y sus costos. Posterior, se ejecutó la asignación de los recursos directos, determinación de los inductores de asignación a actividades, asignación a las actividades, determinación de los inductores de actividades a servicios finales y por último el factor clave de distribución, el establecimiento de los costos totales de los servicios.

Como parte de los resultados obtenidos se pudo identificar en el procedimiento quirúrgico un total de 5 subprocesos, del cual se desprenden 17 actividades realizadas por los colaboradores del área, como: médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y auxiliares, cada uno con una función delimitada y socializada de manera verbal durante la ejecución del

proceso. Con el establecimiento del proceso se induce al conocimiento y comprensión del funcionamiento del mismo, de modo que se alcance una optimización, capacidad de adaptación, cumplimiento de estándares de calidad e innovación para una mejor fluidez en la ejecución de las actividades del proceso. Además, con la determinación del tiempo empleado en las diversas actividades del proceso se proporciona la oportunidad de mejorar la gestión adecuada del tiempo del personal como en el caso de la asignación equitativa de carga laboral y con ello acrecentar la eficiencia laboral, todo en conjunto contribuyendo a una eficiencia operativa para la satisfacción del paciente y al aumento del prestigio del hospital.

Como recursos directos se consideraron los honorarios médicos debido a que existió la posibilidad de identificarlos directamente mediante una tarifa que se estandarizó para el cálculo de los costos. En relación a los costos indirectos, como se pudo observar se encuentran las remuneraciones de las enfermeras y auxiliares y otros recursos indirectos que se asignaron con el modelo ABC por su dificultad de identificación directa hacia el objeto de costo. El reconocimiento de costos directos e indirectos fueron cruciales para el propósito y desarrollo de la investigación porque permitió obtener un análisis más preciso de las cirugías y así también proporcionar al hospital información relevante para una gestión financiera estratégica.

Como resultado de las asignaciones se consiguió el total del costo de las actividades, encontrando a la etapa de intervención específicamente a la actividad número trece: “realización de la cirugía programada” con un mayor consumo de recursos. De esta forma la actividad representa una pertinencia para realizar una evaluación del impacto financiero con diversas estrategias como la optimización de recursos en la cual se reduzcan costos operativos o se dé un control efectivo de costos. Para la siguiente fase, los servicios finales se determinaron en base a los reportes originados por el departamento de contabilidad, los cuales reflejaron a las 5 cirugías más representativas encontrando al parto único por cesárea como la mayor fuente de procedimientos con aproximadamente el dieciséis por ciento del total, lo que podría ser llegar a ser un punto de atención para la organización. Por consiguiente, se continuo con la trazabilidad del método a hacia la asignación a los servicios a través del inductor “número de cirugías realizadas” en donde se logró una distribución porcentual factible a cada una de ellas.

Finalmente, en la última etapa se calcularon los costos totales de los servicios finales o procedimientos quirúrgicos más relevantes, en donde se puede reconocer a la cirugía de desviación del tabique nasal como la más costosa debido a que el número de procedimientos realizados en el periodo fue el menor, y este fue su inductor de distribución, por ello el

resultado obtenido. Luego de esta cirugía se identifican al leiomioma del útero, parto único por cesárea, apendicitis aguda y por último la colelitiasis, ordenadas de acuerdo a lo mencionado. Una vez que se analizaron las cifras, se encuentra que el elemento del costo que más peso representa dentro del total de costo del servicio es la mano de obra directa con más del setenta y cinco por ciento del total, lo que reflejan recursos del personal profesional como un costo de carácter fijo que abarca grandes erogaciones. En cuanto a los costos indirectos de fabricación detallados son asumidos por el hospital sin el conocimiento de que su representatividad indica alrededor del veinticinco por ciento del total del costo del servicio ofrecido, a causa de la carencia de un proceso o sistema de información que refleje costos indirectos reales y diferenciados.

Mediante el análisis del costo total de las cirugías se presenta una visión detallada de los costos en entornos de atención médica y se pretende infundir la importancia de acoger e implementar la metodología del modelo ABC, específicamente en las intervenciones quirúrgicas debido a la necesidad de eficiencia de recursos que se destacan en estos ámbitos. La realización del análisis fue un punto fundamental debido a que logra identificar cuáles de los servicios mencionados son los más abundantes y focalizarse en los servicios que contribuyen significativamente en los resultados financieros para guiar en las decisiones estratégicas sobre la continuidad o modificaciones en la organización que conduzcan a mejores rendimientos empresariales. Además, proporciona fuentes de mejora eficientes y eficaces en la operatividad del área sin comprometer la calidad del servicio y un panorama claro que permite mantener la competitividad con los cambios en las condiciones del mercado.

Recomendaciones

Con la investigación realizada se plantean las siguientes recomendaciones:

- Establecer políticas que permitan la revisión y actualización anual de procesos, actividades, tiempos, recursos invertidos y otros aspectos por parte de la dirección médica, priorizando esta tarea sobre otras actividades, con el fin de agregar valor de manera constante, optimizar los costos y mejorar la capacidad en la toma de decisiones.
- Realizar una supervisión de los recursos invertidos con el objeto de efectuar un sondeo de precios de mercado evitando una sobreestimación en el tiempo.
- Adoptar el análisis de costo unitario mediante el modelo ABC en los procedimientos quirúrgicos de modo que el hospital tenga conocimiento pleno acerca de las erogaciones realizadas y así aprovechar economías de escala y determinar su rentabilidad.
- Se recomienda implementar el Sistema de Costeo Basado en Actividades en el área de Quirófano y en las otras áreas del hospital para lograr un control efectivo de las erogaciones, permitiendo la segmentación a través del uso y análisis detallado de cuentas y recursos. Esto posibilitará la evaluación de la rentabilidad y la identificación de posibles subsidios a servicios obsoletos.
- Se sugiere que la dirección médica revise las tarifas de los médicos, ya que actualmente son consideradas elevadas. Asimismo, se propone establecer métodos más eficientes para la contratación de médicos capacitados de otras ubicaciones, con el objetivo de establecer costos estándares más equitativos en cuanto a la mano de obra médica.
- Implementar una bolsa de empleo por parte del hospital, la cual permita estandarizar las tarifas de servicios médicos para los profesionales que provengan de la ciudad, otras provincias o incluso de otros países. Esta estandarización de tarifas, al tener un impacto positivo en la equidad de los costos laborales, resultaría en una significativa reducción de los gastos asociados.

Referencias

- Hospital San Juan de Dios. (2022). *Hospital San Juan de Dios*. Obtenido de Hospital San Juan de Dios: <https://www.sanjuandedios.med.ec/quienes-somos/mision>
- Balanda, T. (2005). *UNIVERSIDAD NACIONAL de MISIONES FACULTAD de CIENCIAS ECONÓMICAS DEPARTAMENTO de CONTABILIDAD CONTABILIDAD de COSTOS PARTE II-Los Factores del Costo PARTE III-Métodos y Sistemas de Costos*.
- Brito Laredo, J., Ferreiro Martínez, V. V., & López Castañeda, C. E. (2010). *SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES EN LA FABRICACIÓN DE CAMPANAS INDUSTRIALES: APLICACIÓN DEL MODELO ABC COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN*.
- Calleja Bernal, F. J. (2013). *COSTOS* (Pearson, Ed.; Segunda).
- Cuervo Tafur, J., Osorio Agudelo, J. A., & Duque Roldán, M. I. (2013). *Costeo Basado en Actividades ABC* (Segunda). <https://books.google.com.co/books?id=o8G4DQAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Cuevas Villegas, C., Fernando, C., Alberto, J., Marino, N., & Fernando, W. (2004). *COSTEO ABC. ¿POR QUÉ Y CÓMO IMPLANTARLO?* <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209203>
- Duque, M.I., Osorio, J.A. (2003). Sistema de costeo basado en actividades aplicado al sector salud. *Revista Contaduría Universidad de Antioquia*, número 43, julio-diciembre.
- Gosselin, M. (2007). A Review of Activity-Based Costing: Technique, Implementation and Consequences. En Chapman, Hopwood y Shields (Eds.), *Handbook of Management Accounting Research* (pp. 641-671). Elsevier.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN* (Sexta). <https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/biblioteca-digital/ark:/25654/148#?c=0&m=0&s=0&cv=0>
- Horngren T, Srikan M.Datar, & Madhav V.Rajan. (2012). *Contabilidad de-costos* (Decimocuarta edición).

Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1999). *Coste y efecto : cómo usar el ABC, AMB y el ABB para mejorar la gestión, los procesos y la rentabilidad*. Gestion 2000.

Lambretón Torres, V., & Garza Fernández, G. (2016). *Costos para la toma de decisiones* (PEARSON EDUCACIÓN, Ed.).

Lazo Palacios, M. (2013). *Contabilidad de los Costos 1* (Primera edición).

Mallar, M. Á. (2010). LA GESTIÓN POR PROCESOS: UN ENFOQUE DE GESTIÓN EFICIENTE. En Año (Vol. 7). <https://www.redalyc.org/pdf/3579/357935475004.pdf>

Marulanda Castaño, O. J. (2009). *MÓDULO CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS* UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

Renjifo, M. (2013). *Principales Elementos del Sistema de Costeo ABC e Introducción al ABM*. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/23607/22577>

Rincón de Parra, H. C. (2000). *Sistemas de costos: Convencional y actual*. FACES - Mérida: Universidad de los Andes.

Robson-Vicens, C. M., Yohana, M., López, N., & Bertolino, G. (2021). *EL COSTEO POR ACTIVIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS. APLICACIÓN EN EMPRESA DE LOGÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA*.

Sánchez Barraza, B. J. (2009). *PROBLEMÁTICA DE CONCEPTOS DE COSTOS Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS PROBLEM OF COST CONCEPTS AND CLASSIFICATION OF COSTS*. 16(32), 95-104.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS. (2023).

PORTAL DE INFORMACIÓN / CONSULTA DE COMPAÑÍA. Obtenido de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS:

<https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/societario/busquedaCompanias.jsf>

Zapata Sánchez, P. (2015). *Contabilidad de Costos Herramientas para la toma de decisiones* (SEGUNDA EDICIÓN).

Zapata Sánchez, P. (2019). *Contabilidad de costos*.

Anexos

Anexo A: Acuerdo de Confidencialidad



**HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS**

Dir.: Manuel J. Calle 1-59 y Av. Paucarbamba
Telf.: (07) 412-5046
Mail: informacion@sanjuandedios.med.ec
www.sanjuandedios.med.ec
Cuenca - Ecuador

CONTABILIDAD

HSJD-OF-G-074-2023

Cuenca, 7 de junio de 2023

Econ.
Gladys Fernández A.
Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría
Su Despacho.

De mis consideraciones:

En atención al Oficio Externo No.019-C.CONTABILIDAD Y AUDITORIA de fecha 20 de abril del 2023, me permito indicar a Ud. que se autoriza a las estudiantes Méndez Orellana Denise Andrea y Pallango Astudillo Camila Michelle a realizar el trabajo investigativo: Aplicación del Sistema de Costos Basados en Activades (ABC) para los servicios de Hospitalización: Área de Quirófano Asogalenica S.A Hospital San Juan de Dios, tomando en consideración que la información que se obtenga será utilizada únicamente con fines académicos y debe guardarse absoluta confidencialidad.

Por favor solicito remitir el cronograma de actividades, para la coordinación respectiva con el Departamento Contable

Atentamente,



Ing. Manuel Luzuriaga
GERENTE ASOGALENICA



SAN JUAN DE DIOS
Ing. Manuel Luzuriaga O.
GERENTE - ASOGALENICA



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD - PROVEEDORES

PRIMERA. - COMPARECIENTES:

Comparece a la celebración del presente contrato por una parte la Compañía ASOGALENICA S.A., debidamente representado por el DOCTOR RUBÉN ORBE MALLA, en su calidad de Presidente y Representante Legal a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará simplemente "ASOGALENICA" y por otra parte, la EMPRESA Camila Michelle Pallango Astudillo identificada con el RUC Nro. 0107340754, debidamente representada por el Sr. Camila Michelle Pallango Astudillo en su calidad de Estudiante; quien en adelante y para efectos de este documento se denominará "EL PROVEEDOR"; a efectos de celebrar el presente Acuerdo, el cual se registrará por las condiciones que a continuación se indican:

SEGUNDA. - ANCEDENTES: UNO. - Las partes mantienen suscrito un Convenio (convenio, contrato, etc.) el cuyo objeto es tesis, en cuyo ámbito ASOGALENICA permite a el PROVEEDOR el acceso a cierta información, cuya utilización no puede ser distinta sino a efectos del cumplimiento de los objetivos contractuales. DOS. - Que en el marco de la indicada relación contractual ASOGALENICA, suministra información a EL PROVEEDOR y sus servidores por escrito, verbalmente o mediante ficheros digitales, siendo la misma, en general, información de carácter confidencial, que puede incluir entre otros, información comercial, información técnica y financiera, informes de mercadeo, análisis y proyecciones, software, datos y otra información de negocios o técnica a la otra parte. TRES. - Que es intención de las partes, que dicha información se suministre únicamente a quienes conforman el presente acuerdo y sobre la base del contrato que mantienen las partes, siendo menester se extienda la obligación de confidencialidad contenida en este acuerdo, y, por tanto, que dicha información no se divulgue a terceros. CUATRO. - Que es intención de las partes que dicha información no se divulgue a terceros, y sea manejada exclusivamente por quienes suscriben el presente acuerdo y el contrato aludido en el considerando UNO de éste numeral. QUINTO. - Que las partes quieren establecer una protección adecuada a la información mencionada. SEIS. - Que conviene adoptar reglas para garantizar que dicha información no sea revelada indebidamente, ni utilizada de cualquier forma que no sea sino a efectos del cumplimiento de obligaciones contractuales materia del indicado contrato, salvo que exista autorización por escrito de la otra parte o disposición de orden judicial.

TERCERA. - OBJETO: El presente acuerdo tiene por objeto definir los términos y alcances del deber de confidencialidad de las partes, respecto a la información que se maneje en virtud de la relación definida en los considerandos antes aludidos.

La información que entregará ASOGALENICA será suministrada con el único objeto de que ésta pueda ejecutar las actividades materia del convenio/contrato.

CUARTA. - DEFINICIONES: Se entiende por información, todo dato o documentación que en forma verbal, escrita, impresa o digital en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico, magnético o cualquier otro que las partes posean, hayan intercambiado entre ellas, o lleguen a conocer la una de la otra, o en poder de una de ellas. Se entiende por información confidencial, toda información originada, o del conocimiento de quienes integran el presente acuerdo, que por virtud de su naturaleza o de la ley no sea o deba ser del dominio público, frente a la cual exista un deber de sigilo o sobre la cual exista un derecho o una protección contractual, legal y/o constitucional. Se entiende por secreto comercial, toda información que, sin ser reservada por naturaleza, quien la posee alberga un interés legítimo en mantenerla fuera del dominio público.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Con el propósito de facilitar la administración de la información, su titular, en este caso ASOGALENICA tratará de:

- 1- Procurar discriminar por escrito la información que va a suministrar por cualquier medio al receptor, identificando en la carátula el nivel de confidencialidad, restricción, o uso de esta.

www.hospitalsanjuandedios.ec

CODIGO: FR-L-01

VERSION: 1.1

1



- 2- Suministrar al receptor la información que estime necesaria para el desarrollo de las actividades correspondientes.

La ausencia de un rótulo indicando el carácter reservado o no de la información, o su connotación o no de secreto, no releva al receptor de su obligación de confidencialidad frente a tal tipo de información.

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN: Son deberes de quien haga las veces de receptor de la información:

- 1- Guardar la reserva y confidencialidad, sin desmedro de lo previsto en la Cláusula Sexta, respecto de cualquier tipo de información que se le suministre o a la cual llegare a tener acceso o conocimiento.
- 2- Utilizar la información suministrada por el titular de la información o de la que tenga conocimiento, únicamente de la manera y para los fines establecidos en el contrato suscrito y este acuerdo, en los documentos que hacen parte de este o en dicha información.
- 3- Devolver toda la información recibida junto con todas las copias que de ella hubiere, inmediatamente a la solicitud del titular de la información, mediante relación escrita del material entregado, firmado por las partes o con sello de recibido.
- 4- No realizar copia o duplicado alguno de la información mencionada en este acuerdo; tampoco podrán divulgar dicha información a tercera persona sin que medie igualmente autorización previa y escrita de la otra parte.
- 5- Suministrar al receptor la información que estime necesaria para el desarrollo de proyectos.
- 6- No permitir que sus servidores o dependientes utilicen la información sino para los fines contractuales, debiendo para el efecto tomar las acciones del caso.
- 7- Responder por un uso inadecuado de la información incurrido por alguno de sus servidores o dependientes.

SÉPTIMA. - PATRÓN DE CONDUCTA, IMPLICACIONES DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD: Las partes actuarán con el parámetro de responsabilidad del buen comerciante en sus propios negocios, lo que supone entre otros deberes, limitar la divulgación autorizada al menor número de personas, y el de tomar las medidas idóneas y eficaces para evitar el tráfico y fuga indebida de la información, así como su uso por fuera de los límites de este contrato.

El incumplimiento del deber de reserva establecido en la Cláusula Cuarta de este acuerdo constituye violación de secreto y justa causa de terminación unilateral del contrato suscrito entre las partes, sin desmedro de las indemnizaciones legales correspondientes y de las responsabilidades penales en que incurra el trasgresor.

Las partes reconocen que la información confidencial a la que se refiere el presente acuerdo posee una valoración económica y su indebida divulgación o utilización causa un perjuicio.

OCTAVA. - EXCLUSIONES. - Este acuerdo no impone ninguna obligación a cargo del receptor de información confidencial respecto de:

- 1- Información que de derecho ya se encontraba en su poder al ser enviada por la otra parte o que, de otro modo, previamente haya sido objeto de su conocimiento, todo lo anterior, siempre y cuando así se haya informado por escrito a la otra parte al momento de recibir tal información y cuando su divulgación tenga una causa legítima.
- 2- Información disgregada que sea del dominio público al momento de recibirla, o que haya pasado a ser del dominio público sin que obre negligencia, culpa o dolo por parte del receptor.
- 3- Información que de derecho haya sido recibida por el receptor de terceros que no estaban obligados a guardar confidencialidad.
- 4- Información que sea revelada por el titular a terceros sin exigirles confidencialidad.

www.hospitalsanjuandedios.ec

CODIGO: FR-L-01
VERSION: 1.1
2



- 5- Información que sea desarrollada autónoma e independientemente por el receptor al margen de la relación, esto es, sin que exista un aprovechamiento de la información recibida.
- 6- Información que deba ser revelada bajo alguna ley o regulación emanada legítimamente del Estado.
- 7- Información que deba ser revelada por decisión judicial o de autoridad competente, siempre y cuando, de manera oportuna, se haya notificado de este hecho al titular y se le haya permitido una defensa efectiva en relación con su interés de mantenerla en reserva.
- 8- Información que sea revelada por el receptor con aprobación escrita previa de su titular.

NOVENA. - TITULARIDAD: La parte receptora de la información no mantiene titularidad sobre la información suministrada y, por lo tanto, únicamente la utilizará para los fines y de la manera establecida en este contrato, en los documentos que hagan parte del mismo o en dicha información.

El acceso a la información no implica la transferencia de derecho alguno sobre tal información, tales como derechos derivados de la transferencia de tecnología, know-how, derechos de autor, patente u otros derechos intangibles.

DÉCIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE: En el evento de suscitarse cualquier controversia en relación con la ejecución del presente acuerdo, la legislación aplicable será la de la República de Ecuador.

DÉCIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL: Este acuerdo incluye el total entendimiento entre las partes con relación a la materia de la cual se trata este documento. Cualquier añadidura o modificación a este acuerdo deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas partes.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente acuerdo las partes se sujetarán a arbitraje en derecho ante el Centro de Mediación y Arbitraje de las Cámaras de la Producción del Azuay.

DÉCIMA TERCERA. - DURACIÓN: Las obligaciones de confidencialidad adquiridas por el presente acuerdo deberán mantenerse durante el periodo de ejecución del contrato y hasta un plazo de tres (3) años contados a partir de la terminación del indicado contrato.

En constancia de aceptación de todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente instrumento, las partes lo suscriben en unidad de acto y por duplicado en el lugar y fecha antes señalados.

Cuenca, ...

Representante Legal
ASOGALENICA


Representante Legal
EL PROVEEDOR



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD - PROVEEDORES

PRIMERA. - COMPARECIENTES:

Comparece a la celebración del presente contrato por una parte la Compañía ASOGALENICA S.A., debidamente representado por el DOCTOR RUBÉN ORBE MALLA, en su calidad de Presidente y Representante Legal a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará simplemente "ASOGALENICA" y por otra parte, la EMPRESA Denisse Andrea Méndez Orellana identificada con el RUC Nro. 015022138 debidamente representada por el Sr. Denisse Andrea Méndez Orellana en su calidad de Estudiante; quien en adelante y para efectos de este documento se denominará "EL PROVEEDOR"; a efectos de celebrar el presente Acuerdo, el cual se registrará por las condiciones que a continuación se indican:

SEGUNDA. - ANCEDENTES: UNO. - Las partes mantienen suscrito un Convenio (convenio, contrato, etc.) el cuyo objeto es Teoría, en cuyo ámbito ASOGALENICA permite a el PROVEEDOR el acceso a cierta información, cuya utilización no puede ser distinta sino a efectos del cumplimiento de los objetivos contractuales. DOS. - Que en el marco de la indicada relación contractual ASOGALENICA, suministra información a EL PROVEEDOR y sus servidores por escrito, verbalmente o mediante ficheros digitales, siendo la misma, en general, información de carácter confidencial, que puede incluir entre otros, información comercial, información técnica y financiera, informes de mercadeo, análisis y proyecciones, software, datos y otra información de negocios o técnica a la otra parte. TRES. - Que es intención de las partes, que dicha información se suministre únicamente a quienes conforman el presente acuerdo y sobre la base del contrato que mantienen las partes, siendo menester se extienda la obligación de confidencialidad contenida en este acuerdo, y, por tanto, que dicha información no se divulgue a terceros. CUATRO. - Que es intención de las partes que dicha información no se divulgue a terceros, y sea manejada exclusivamente por quienes suscriben el presente acuerdo y el contrato aludido en el considerando UNO de éste numeral. QUINTO. - Que las partes quieren establecer una protección adecuada a la información mencionada. SEIS. - Que conviene adoptar reglas para garantizar que dicha información no sea revelada indebidamente, ni utilizada de cualquier forma que no sea sino a efectos del cumplimiento de obligaciones contractuales materia del indicado contrato, salvo que exista autorización por escrito de la otra parte o disposición de orden judicial.

TERCERA. - OBJETO: El presente acuerdo tiene por objeto definir los términos y alcances del deber de confidencialidad de las partes, respecto a la información que se maneje en virtud de la relación definida en los considerandos antes aludidos.

La información que entregará ASOGALENICA será suministrada con el único objeto de que ésta pueda ejecutar las actividades materia del convenio/contrato.

CUARTA. - DEFINICIONES: Se entiende por información, todo dato o documentación que en forma verbal, escrita, impresa o digital en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico, magnético o cualquier otro que las partes posean, hayan intercambiado entre ellas, o lleguen a conocer la una de la otra, o en poder de una de ellas. Se entiende por información confidencial, toda información originada, o del conocimiento de quienes integran el presente acuerdo, que por virtud de su naturaleza o de la ley no sea o deba ser del dominio público, frente a la cual exista un deber de sigilo o sobre la cual exista un derecho o una protección contractual, legal y/o constitucional. Se entiende por secreto comercial, toda información que, sin ser reservada por naturaleza, quien la posee alberga un interés legítimo en mantenerla fuera del dominio público.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Con el propósito de facilitar la administración de la información, su titular, en este caso ASOGALENICA tratará de:

- 1- Procurar discriminar por escrito la información que va a suministrar por cualquier medio al receptor, identificando en la carátula el nivel de confidencialidad, restricción, o uso de esta.

www.hospitalsanjuandedios.ec

CODIGO: FR-L-01
VERSION: 1.1

1



- 2- Suministrar al receptor la información que estime necesaria para el desarrollo de las actividades correspondientes.

La ausencia de un rótulo indicando el carácter reservado o no de la información, o su connotación o no de secreto, no releva al receptor de su obligación de confidencialidad frente a tal tipo de información.

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN: Son deberes de quien haga las veces de receptor de la información:

- 1- Guardar la reserva y confidencialidad, sin desmedro de lo previsto en la Cláusula Sexta, respecto de cualquier tipo de información que se le suministre o a la cual llegare a tener acceso o conocimiento.
- 2- Utilizar la información suministrada por el titular de la información o de la que tenga conocimiento, únicamente de la manera y para los fines establecidos en el contrato suscrito y este acuerdo, en los documentos que hacen parte de este o en dicha información.
- 3- Devolver toda la información recibida junto con todas las copias que de ella hubiere, inmediatamente a la solicitud del titular de la información, mediante relación escrita del material entregado, firmado por las partes o con sello de recibido.
- 4- No realizar copia o duplicado alguno de la información mencionada en este acuerdo; tampoco podrán divulgar dicha información a tercera persona sin que medie igualmente autorización previa y escrita de la otra parte.
- 5- Suministrar al receptor la información que estime necesaria para el desarrollo de proyectos.
- 6- No permitir que sus servidores o dependientes utilicen la información sino para los fines contractuales, debiendo para el efecto tomar las acciones del caso.
- 7- Responder por un uso inadecuado de la información incurrido por alguno de sus servidores o dependientes.

SÉPTIMA. - PATRÓN DE CONDUCTA, IMPLICACIONES DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD: Las partes actuarán con el parámetro de responsabilidad del buen comerciante en sus propios negocios, lo que supone entre otros deberes, limitar la divulgación autorizada al menor número de personas, y el de tomar las medidas idóneas y eficaces para evitar el tráfico y fuga indebida de la información, así como su uso por fuera de los límites de este contrato.

El incumplimiento del deber de reserva establecido en la Cláusula Cuarta de este acuerdo constituye violación de secreto y justa causa de terminación unilateral del contrato suscrito entre las partes, sin desmedro de las indemnizaciones legales correspondientes y de las responsabilidades penales en que incurra el trasgresor.

Las partes reconocen que la información confidencial a la que se refiere el presente acuerdo posee una valoración económica y su indebida divulgación o utilización causa un perjuicio.

OCTAVA. - EXCLUSIONES. - Este acuerdo no impone ninguna obligación a cargo del receptor de información confidencial respecto de:

- 1- Información que de derecho ya se encontraba en su poder al ser enviada por la otra parte o que, de otro modo, previamente haya sido objeto de su conocimiento, todo lo anterior, siempre y cuando así se haya informado por escrito a la otra parte al momento de recibir tal información y cuando su divulgación tenga una causa legítima.
- 2- Información disgregada que sea del dominio público al momento de recibirla, o que haya pasado a ser del dominio público sin que obre negligencia, culpa o dolo por parte del receptor.
- 3- Información que de derecho haya sido recibida por el receptor de terceros que no estaban obligados a guardar confidencialidad.
- 4- Información que sea revelada por el titular a terceros sin exigirles confidencialidad.

www.hospitalsanjuandedios.ec

CODIGO: FR-L-01
VERSION: 1.1

2



- 5- Información que sea desarrollada autónoma e independientemente por el receptor al margen de la relación, esto es, sin que exista un aprovechamiento de la información recibida.
- 6- Información que deba ser revelada bajo alguna ley o regulación emanada legítimamente del Estado.
- 7- Información que deba ser revelada por decisión judicial o de autoridad competente, siempre y cuando, de manera oportuna, se haya notificado de este hecho al titular y se le haya permitido una defensa efectiva en relación con su interés de mantenerla en reserva.
- 8- Información que sea revelada por el receptor con aprobación escrita previa de su titular.

NOVENA. - TITULARIDAD: La parte receptora de la información no mantiene titularidad sobre la información suministrada y, por lo tanto, únicamente la utilizará para los fines y de la manera establecida en este contrato, en los documentos que hagan parte del mismo o en dicha información.

El acceso a la información no implica la transferencia de derecho alguno sobre tal información, tales como derechos derivados de la transferencia de tecnología, know-how, derechos de autor, patente u otros derechos intangibles.

DÉCIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE: En el evento de suscitarse cualquier controversia en relación con la ejecución del presente acuerdo, la legislación aplicable será la de la República de Ecuador.

DÉCIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL: Este acuerdo incluye el total entendimiento entre las partes con relación a la materia de la cual se trata este documento. Cualquier añadidura o modificación a este acuerdo deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas partes.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente acuerdo las partes se sujetarán a arbitraje en derecho ante el Centro de Mediación y Arbitraje de las Cámaras de la Producción del Azuay.

DÉCIMA TERCERA. - DURACIÓN: Las obligaciones de confidencialidad adquiridas por el presente acuerdo deberán mantenerse durante el periodo de ejecución del contrato y hasta un plazo de tres (3) años contados a partir de la terminación del indicado contrato.

En constancia de aceptación de todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente instrumento, las partes lo suscriben en unidad de acto y por duplicado en el lugar y fecha antes señalados.

Cuenca, ...

Representante Legal
ASOGALENICA

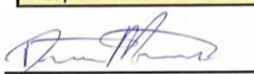

Representante Legal
EL PROVEEDOR

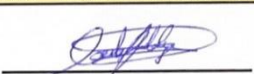
www.hospitalsanjuanededios.ec

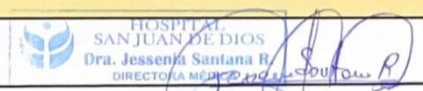
CODIGO: FR-L-01
VERSION: 1.1
3

Anexo B: Ficha de Procesos

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS FICHA DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de recibir al paciente.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Valoración prequirúrgica precisa del paciente con el fin de garantizar una gestión eficiente de los recursos económicos				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	QUIRÓFANO	RECURSOS MATERIALES/FÍSICOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS HUMANOS
VALORACIÓN PRE-QUIRÚRGICA	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anesthesiologist	Jefe de Quirófano	Costo de medicamentos e insumos Uniformes personal Suministros de oficina Depreciación Edificio	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Comunicación del diagnóstico del paciente al anesthesiologist	Jefe de Quirófano	Uniformes personal Depreciación Edificio	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano	Jefe de Quirófano	Uniformes personal Depreciación Edificio	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
Observaciones Responsible de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					


Firmas Responsables de la Entrevista


Firmas Responsables de la Entrevista


Firma Responsable Validación: Dirección Medica


Jefa de Contabilidad

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS FICHA DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de recibir al paciente.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Asegurar la adecuada preparación y organización del quirófano, para proporcionar un entorno seguro				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	QUIRÓFANO	RECURSOS MATERIALES/FÍSICOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS HUMANOS
PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	Enfermera	Arriendo Equipos Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano	Enfermera Circulante	Costo de medicamentos e insumos Arriendo Equipos Servicio de Agua Potable Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Preparación del personal a intervenir en la cirugía	Enfermera Anestesiólogo Enfermera circulante Médico tranate	Costo de medicamentos e insumos Arriendo Equipos Servicio de Agua Potable Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal

Observaciones
Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango




Firmas Responsables de la Entrevista



Firma Responsable Validación: Dirección Médica



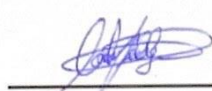
Jefa de Contabilidad

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS FICHA DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de recibir al paciente.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, con el objetivo de mejorar la salud del paciente, abordar las necesidades médicas específicas y garantizar resultados exitosos				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	QUIRÓFANO	RECURSOS MATERIALES/FÍSICOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS HUMANOS
INTERVENCIÓN	Verificación de datos generales previo a la operación	Jefe de Quirófano	Arriendo Equipos Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo Médico Depreciación Otros PPE	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Intervención del anestesiólogo	Jefe de Quirófano	Costo de medicamentos e insumos Arriendo Equipos Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo Médico Depreciación Otros PPE	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Intervención del cuerpo clínico y	Jefe de Quirófano	Costo de medicamentos e insumos	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras

	médico quirúrgico		Arriendo Equipos Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo Médico Depreciación Otros PPE		Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Realización de la cirugía programada	Médico tratante	Costo de medicamentos e insumos Arriendo Equipos Servicio de Energía Eléctrica Uniformes personal Suministros de operación Gases medicinales Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo Médico Depreciación Otros PPE	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
Observaciones Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					



Firmas Responsables de la Entrevista




Firma Responsable Validación: Dirección Medica



Jefa de Contabilidad

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS					
FICHA DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de recibir al paciente.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Brindar un cuidado postoperatorio , centrado en el paciente, que facilite una recuperación segura, efectiva y confortable.				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	QUIRÓFANO	RECURSOS MATERIALES/FÍSICOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS HUMANOS
RECUPERACIÓN	Ingreso a la sala de post Operatorio	Enfermera	Costo de medicamentos e insumos Mantenimiento Equipos Mantenimientos varios Mantenimiento de Edificio Servicio de Agua Potable Uniformes personal Suministros de Limpieza Servicio de lavado Consumo Interno Lencería Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.	Enfermera	Mantenimiento Equipos Mantenimientos varios Mantenimiento de Edificio Servicio de Agua Potable Uniformes personal Suministros de Limpieza Servicio de lavado Consumo Interno Lencería Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	El médico tratante (anestesiólogo)	Anestesiólogo	Mantenimiento Equipos Mantenimientos varios Mantenimiento de Edificio	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos

	autoriza egreso del paciente y define ruta.		Uniformes personal Suministros de Limpieza Servicio de lavado Consumo Interno Lencería Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo		Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
	El paciente pasa a piso	Enfermera	Mantenimiento Equipos Mantenimientos varios Mantenimiento de Edificio Servicio de Agua Potable Uniformes personal Suministros de Limpieza Servicio de lavado Consumo Interno Lencería Depreciación Edificio Depreciación Muebles y Enseres Mantenimiento y reparaciones de equipos Correctivo	Servicio de Internet	Sueldos y Salarios Horas extras Bonos Aportes patronales Fondos de reserva Décimo tercer sueldo personal Décimo cuarto sueldo personal Vacaciones personal
Observaciones					
Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					



Firmas Responsables de la Entrevista



Firma Responsable Validación: Dirección Medica



Jefa de Contabilidad

Anexo C: Registro de Tiempo de Procesos

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGISTRO DE TIEMPO DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de Valoración Pre-Quirúrgica.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Valoración prequirúrgica precisa del paciente con el fin de garantizar una gestión eficiente de los recursos económicos				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) SUBPROCESO	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TIEMPO POR SUBPROCESO	PORCENTAJE DE TIEMPO POR ACTIVIDAD
VALORACIÓ PRE-QUIRÚRGICA	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	15	3	20%	1.54%
	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo		3	20%	1.54%
	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano		9	60%	4.62%
Observaciones Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					



Firmas Responsables de la Entrevista




Firma Responsable Validación: Jefa de Quirófano

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGISTRO DE TIEMPO DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de recibir al paciente.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Asegurar la preparación óptima y la atención segura del paciente en el proceso de ingreso a la sala de operaciones				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) SUBPROCESO	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TIEMPO POR SUBPROCESO	PORCENTAJE DE TIEMPO POR ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DEL PACIENTE	Recepción del paciente prequirúrgico	10	2	20%	1.03%
	Verificación de datos del paciente		3	30%	1.54%
	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria		5	50%	2.56%
Observaciones					
Responsable de la toma de datos		Denisse Méndez - Camila Pallango			




Firmas Responsables de la Entrevista



HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
Lcda. Gabriela Mejía
COORDINACIÓN QUIRÓFANO

Firma Responsable Validación: Jefe de Quirófano

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGISTRO DE TIEMPO DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de Preparación del Quirófano.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Asegurar la adecuada preparación y organización del quirófano, para proporcionar un entorno seguro				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) SUBPROCESO	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TIEMPO POR SUBPROCESO	PORCENTAJE DE TIEMPO POR ACTIVIDAD
PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	20	5	25%	2.56%
	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano		11	55%	5.64%
	Preparación del personal a intervenir en la cirugía		4	20%	2.05%
Observaciones					
Responsable de la toma de datos		Denisse Méndez - Camila Pallango			




Firmas Responsables de la Entrevista



Firma Responsable Validación: Jefa de Quirófano

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGISTRO DE TIEMPO DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de Intervención.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, con el objetivo de mejorar la salud del paciente, abordar las necesidades médicas específicas y garantizar resultados exitosos				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) SUBPROCESO	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TIEMPO POR SUBPROCESO	PORCENTAJE DE TIEMPO POR ACTIVIDAD
INTERVENCIÓN	Verificación de datos generales previo a la operación	90	3	3.33%	1.54%
	Intervención del anestesiólogo		7	7.78%	3.59%
	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico		5	5.56%	2.56%
	Realización de la cirugía programada		75	83.33%	38.46%
Observaciones					
Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					

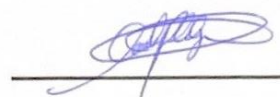



Firmas Responsables de la Entrevista



Firma Responsable Validación: Jefa de Quirófano

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS REGISTRO DE TIEMPO DE PROCESOS					
Introducción	En esta ficha se detallan las acciones que realiza el encargado en el proceso de Recuperación.				
Responsable	Jefe de Quirófano				
Departamento	Quirófano				
Proceso	Cirugía (Quirófano)				
Misión del Proceso Práctico	Brindar un cuidado postoperatorio, centrado en el paciente, que facilite una recuperación segura, efectiva y confortable.				
SUBPROCESO	ACTIVIDADES	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) SUBPROCESO	TIEMPO (EXPRESADO EN MINUTOS) ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TIEMPO POR SUBPROCESO	PORCENTAJE DE TIEMPO POR ACTIVIDAD
RECUPERACIÓN	Ingreso a la sala de post Operatorio	60	5	8.33%	2.56%
	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.		30	50%	15.38%
	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.		5	8.33%	2.56%
	El paciente pasa a piso		20	33.33%	10.26%
Observaciones Responsable de la toma de datos Denisse Méndez - Camila Pallango					

Firmas Responsables de la Entrevista



Firma Responsable Validación: Jefa de Quirófano

Anexo D: Entrevistas



Carrera de Contabilidad y Auditoría

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN: ÁREA DE QUIRÓFANO DE ASOGALENICA S.A. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Autor de Tesis: Denisse Méndez

denisse.mendez@ucuenca.edu.ec

Autor de Tesis: Camila Pallango

camila.pallango@ucuenca.edu.ec

Tutor: CPA. Marco Peralta Zúñiga

marco.peralta2901@ucuenca.edu.ec

ENTREVISTA A LA DIRECCIÓN MÉDICA

Objetivo: Conocer la situación actual del Hospital San Juan de Dios dentro del área de quirófano.

Entrevistado: Dra. Jesenia Isabel Santana Romero.

1. ¿Cuántos quirófanos tiene el Hospital?
2. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza al paciente para las cirugías desde que entra hasta que se termina la cirugía?
3. ¿Cuántas personas intervienen en la cirugía?
4. ¿Cuántas operaciones realizan diariamente en el quirófano?
5. ¿Cuántas especialidades se manejan dentro de los quirófanos?
6. ¿Quién es el responsable de cada quirófano?
7. ¿Existe registros de cuantas cirugías se hicieron en el año 2022?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) PARA LOS
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN: ÁREA DE QUIRÓFANO DE ASOGALENICA S.A.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Autor de Tesis: Denisse Méndez

denisse.mendez@ucuenca.edu.ec

Autor de Tesis: Camila Pallango

camila.pallango@ucuenca.edu.ec

Tutor: CPA. Marco Peralta Zúñiga

marco.peralta2901@ucuenca.edu.ec

ENTREVISTA A LA JEFA DE QUIROFANO

Objetivo: Conocer la situación actual del Hospital San Juan de Dios dentro del área de quirófano.

Entrevistado: Lic. Inés Gabriela Mejía Pacheco

1. ¿Qué tiempo toma aproximadamente una operación?
2. ¿Cuáles son los insumos médicos que utilizan frecuentemente en las cirugías?
3. ¿Para la parte de higiene en que etapas se realizan en el quirófano?
4. ¿Existen registros de las cirugías planificadas en cada quirófano?
5. ¿Cuántas enfermeras son parte del área de quirófano?
6. ¿Cada que tiempo le dan mantenimiento a los equipos e implementos del quirófano?
7. ¿En qué actividades se utiliza el recurso de agua potable y cuantas personas utilizan en esa área?
8. ¿Qué tiempo toma cada actividad que se realiza en el proceso de la cirugía en el quirófano?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



Carrera de Contabilidad y Auditoría

**APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) PARA LOS
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN: ÁREA DE QUIRÓFANO DE ASOGALENICA S.A.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Autor de Tesis: Denisse Méndez

denisse.mendez@ucuenca.edu.ec

Autor de Tesis: Camila Pallango

camila.pallango@ucuenca.edu.ec

Tutor: CPA. Marco Peralta Zúñiga

marco.peralta2901@ucuenca.edu.ec

ENTREVISTA A LA JEFA DE CONTABILIDAD

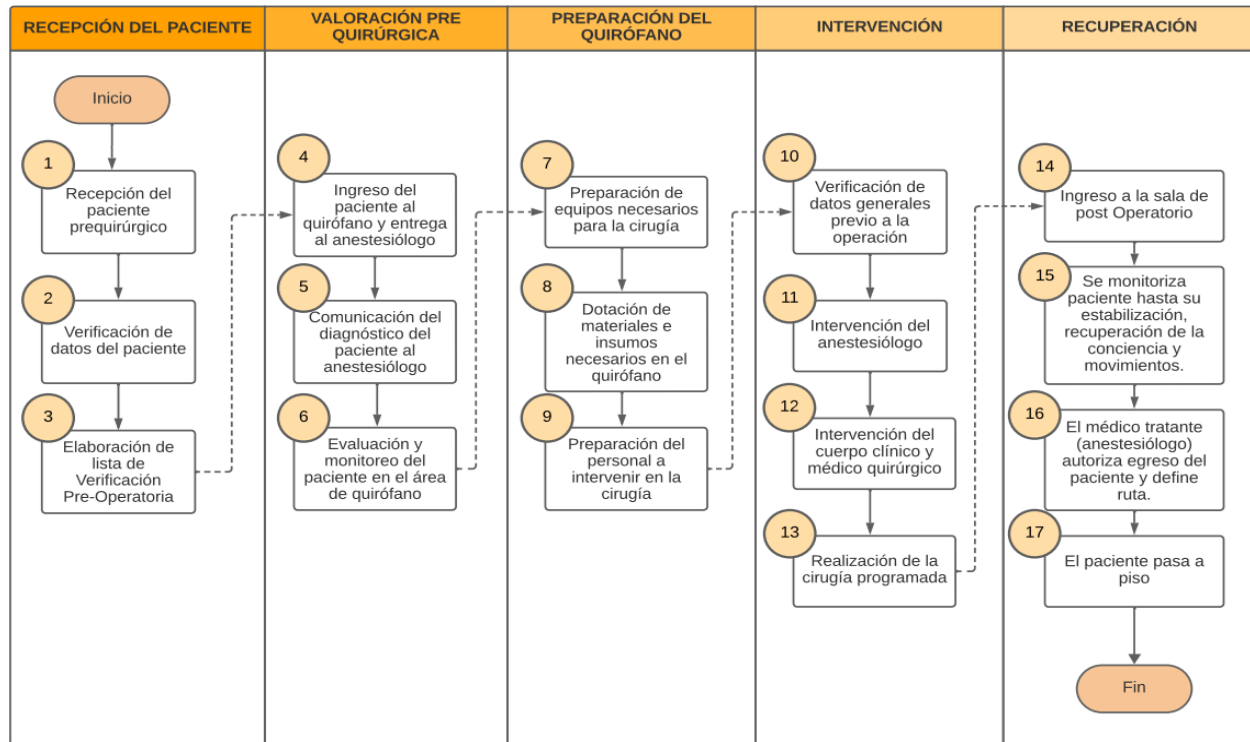
Objetivo: Conocer la situación actual del Hospital San Juan de Dios dentro del área de quirófano.

Entrevistado: Ing. María José Ayala Álvarez

1. ¿Cómo manejan los registros de las cirugías que se realizan?
2. ¿Las depreciaciones se manejan por área?
3. ¿Cuáles son las prácticas contables para registrar la utilización de materiales y suministros durante procedimientos quirúrgicos?
4. ¿Los mayores lo manejan por áreas del hospital?
5. ¿Los servicios básicos cómo se manejan para el área de quirófano?
6. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el área de hospitalización y el área de quirófano?
7. ¿Cómo se realiza el pago y registro tanto para las enfermeras del área de quirófano y para los médicos tratantes que realizan la cirugía?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo E: Diagrama de Flujos de Subprocesos y Actividades



Anexo F: Honorarios Médicos Estandarizados

PARTO ÚNICO POR CESÁREA	
Honorarios Cirujanos	
\$	820,00
\$	950,00
\$	996,00
\$	770,00
\$	910,00
\$	990,00
\$	940,00
\$	1.070,00
\$	860,00
\$	960,00
\$	985,00
\$	840,00
\$	945,00

PARTO ÚNICO POR CESÁREA	CIRUJANOS
PROMEDIO	\$ 925,85
DESVIACIÓN ESTANDAR	83,21
MIN	\$ 770,00
MAX	\$ 1.070,00

LEIOMIOMA	
Honorarios	
Cirujano	Anestesiólogo
\$ 1.620,00	\$ 210,00
\$ 1.065,00	\$ 220,00
\$ 1.065,00	\$ 150,00
\$ 810,00	\$ 220,00
\$ 1.265,00	\$ 165,00
\$ 1.455,00	\$ 210,00
\$ 967,60	\$ 245,70
\$ 1.055,00	\$ 150,00
\$ 1.335,00	\$ 280,00
\$ 1.230,00	\$ 160,00
\$ 892,00	\$ 285,00
\$ 1.323,00	\$ 230,00
\$ 973,00	\$ 160,00
\$ 1.200,00	\$ 130,00
\$ 905,00	\$ 175,00
\$ 1.565,00	\$ 250,00
\$ 897,00	\$ 130,00
\$ 1.050,00	\$ 150,00
\$ 1.555,00	\$ 190,00
\$ 884,00	\$ 130,00
\$ 785,00	\$ 380,00
\$ 1.090,00	\$ 160,00
\$ 849,32	\$ 219,24
\$ 1.014,00	\$ 130,00
\$ 1.022,84	\$ 240,00
\$ 1.555,00	\$ 155,00
\$ 1.421,27	\$ 250,00
\$ 1.295,00	\$ 198,00
\$ 1.035,00	\$ 270,00
\$ 1.666,00	\$ 150,00
\$ 965,00	\$ 150,00
\$ 1.610,00	\$ 225,00
\$ 1.545,00	\$ 138,00
\$ 1.325,00	\$ 198,00
\$ 1.215,00	\$ 226,63
\$ 896,75	\$ 175,00
\$ 1.440,00	\$ 425,00
\$ 1.570,00	\$ 220,00
\$ 890,00	\$ 160,00
\$ 1.290,00	\$ 172,00
\$ 1.640,00	\$ 190,00
\$ 1.379,00	\$ 220,00
\$ 1.070,00	\$ 230,00
\$ 1.030,00	\$ 200,00
\$ 940,00	\$ 210,00
\$ 1.335,00	\$ 130,00
\$ 865,00	\$ 145,00
\$ 939,00	\$ 150,00
\$ 1.035,00	\$ 190,00
\$ 940,00	\$ 182,00
\$ 620,00	\$ 130,00
\$ 1.123,00	\$ 190,00
\$ 1.048,00	\$ 175,00

LEIOMIOMA	CIRUJANOS	ANESTESIÓLOGOS
PROMEDIO	\$ 1.161,43	\$ 196,69
DESVIACIÓN ESTANDAR	267,46	58,73
MAX	\$ 1.666,00	\$ 425,00

DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL	
Honorarios	
Cirujano	Anestesiólogo
\$ 1.700,00	\$ 285,00
\$ 1.366,00	\$ 330,00
\$ 781,56	\$ 210,42
\$ 1.640,00	\$ 285,00
\$ 965,00	\$ 250,00
\$ 1.695,00	\$ 225,00
\$ 716,43	\$ 192,88
\$ 1.657,00	\$ 308,00
\$ 3.260,00	\$ 338,00
\$ 2.505,00	\$ 360,00
\$ 1.030,00	\$ 200,00
\$ 1.576,00	\$ 232,50
\$ 1.755,00	\$ 240,00
\$ 1.702,00	\$ 300,00
\$ 1.890,00	\$ 240,00
\$ 1.865,00	\$ 180,00
\$ 1.655,00	\$ 285,00
\$ 2.818,00	\$ 400,00
\$ 1.690,00	\$ 195,00
\$ 1.900,00	\$ 270,00
\$ 2.780,00	\$ 540,00
\$ 1.800,00	\$ 285,00
\$ 1.497,00	\$ 255,00
\$ 1.428,00	\$ 330,00
\$ 1.740,00	\$ 250,00
\$ 1.655,00	\$ 262,00
\$ 1.990,00	\$ 250,00
\$ 1.704,00	\$ 225,00
\$ 1.231,00	\$ 352,00
\$ 3.750,00	\$ 427,00
\$ 913,00	\$ 200,00

DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL	CIRUJANOS	ANESTESIÓLOGOS
PROMEDIO	\$ 1.763,06	\$ 280,74
DESVIACIÓN ESTANDAR	675,04	78,00
MIN	\$ 716,43	\$ 180,00
MAX	\$ 3.750,00	\$ 540,00

APENDICITIS AGUDA	
Honorarios	
Cirujano	Anestesiólogo
\$ 235,00	\$ 160,00
\$ 830,00	\$ 130,00
\$ 1.465,00	\$ 150,00
\$ 650,00	\$ 150,00
\$ 120,00	\$ 150,00
\$ 785,00	\$ 150,00
\$ 830,00	\$ 150,00
\$ 605,00	\$ 150,00
\$ 785,00	\$ 150,00
\$ 990,00	\$ 150,00
\$ 2.320,00	\$ 150,00
\$ 615,00	\$ 150,00
\$ 130,00	\$ 130,00
\$ 735,00	\$ 150,00

APENDICITIS AGUDA	CIRUJANOS	ANESTESIÓLOGOS
PROMEDIO	\$ 792,50	\$ 147,86
DESVIACIÓN ESTANDAR	562,94	8,02
MIN	\$ 120,00	\$ 130,00
MAX	\$ 2.320,00	\$ 160,00

COLELITIASIS	
Honorarios	
Cirujano	Anestesiólogo
\$ 800,00	\$ 150,00
\$ 830,00	\$ 150,00
\$ 1.040,00	\$ 150,00
\$ 1.050,00	\$ 170,00
\$ 553,12	\$ 233,10
\$ 480,00	\$ 300,00
\$ 690,00	\$ 200,00
\$ 155,00	\$ 150,00
\$ 150,00	\$ 150,00
\$ 120,00	\$ 150,00
\$ 1.054,00	\$ 173,00
\$ 200,00	\$ 150,00
\$ 920,00	\$ 150,00
\$ 1.310,00	\$ 265,00
\$ 110,00	\$ 200,00
\$ 1.200,00	\$ 150,00
\$ 100,00	\$ 150,00
\$ 1.000,00	\$ 255,00
\$ 960,00	\$ 150,00
\$ 786,00	\$ 150,00
\$ 1.635,00	\$ 270,00
\$ 750,00	\$ 202,00
\$ 940,00	\$ 150,00
\$ 480,95	\$ 233,10
\$ 800,00	\$ 150,00
\$ 835,00	\$ 160,00
\$ 885,00	\$ 150,00
\$ 870,00	\$ 165,00
\$ 1.140,00	\$ 225,00
\$ 635,00	\$ 130,00
\$ 165,00	\$ 150,00
\$ 150,00	\$ 150,00
\$ 895,00	\$ 150,00
\$ 135,00	\$ 150,00
\$ 445,00	\$ 150,00
\$ 922,00	\$ 150,00
\$ 1.325,00	\$ 150,00
\$ 180,00	\$ 150,00
\$ 370,00	\$ 175,00
\$ 826,00	\$ 150,00
\$ 200,00	\$ 160,00
\$ 190,00	\$ 150,00
\$ 805,00	\$ 150,00
\$ 1.000,00	\$ 210,00
\$ 1.140,00	\$ 150,00
\$ 1.455,00	\$ 150,00
\$ 150,00	\$ 150,00

COLELITIASIS	CIRUJANOS	ANESTESIÓLOGOS
PROMEDIO	\$ 698,55	\$ 171,83
DESVIACIÓN ESTANDAR	416,63	39,53
MIN	\$ 100,00	\$ 130,00
MAX	\$ 1.635,00	\$ 300,00

Anexo G: Listado Estandarizado de Medicamentos e Insumos

ACTIVIDADES	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	Unid.	Cost. Unit	Costo Total	REPRESENTATIVIDAD
1	GORRO QUIRURGICO ENFERMERA T/ACORDEON	3	0,051	0,15	0,184%
2					0,000%
3					0,000%
4	*PROTECTOR DE CAMA X1 UND	1	0,714	0,71	0,872%
	JERING DESCART.10CC 21GX11/2 NIPRO	1	0,134	0,13	0,160%
	SPINOJECT TROGE #27	1	3,78	3,78	4,643%
	MANGUERA DE SUCCION 3.00MTS	1	2,498	2,5	3,070%
	SABANA DESCARTABLE RESORTADA X1	1	1,019	1,02	1,253%
	LACTATO DE RINGER X1000ML BAXTER (LACTATO DE RINGER)	1	1,55	1,55	1,904%
	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP X1 SANDERSON (ONDANSETRON)	1	1,131	1,13	1,388%
5					0,000%
6					0,000%
7					0,000%
8	GUANTE ESTERIL #6,5 PERRY/VARIOS	1	1,161	1,16	1,425%
	ENVASE RECOLECTOR DE ORINA	1	0,223	0,22	0,270%
	COMPRESA NO ESTERIL 8 CAPAS X1 DISHVE	3	1,458	4,37	5,367%
	JERING DESCART.20CC 21GX1 1/2" NIPRO	1	0,223	0,22	0,270%
	JERING DESCART.10CC 21GX11/2 NIPRO	1	0,134	0,13	0,160%
	JERING DESCART.5CC 21X1:1/4 NIPRO	2	0,091	0,18	0,221%
	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO X50 UND	1	0,1	0,1	0,123%
9	BOTAS DESCARTABLES ANTIDESLIZANTES X1PAR	6	0,446	2,68	3,292%
	GUANTES DE EXAMINACION MEDIUM X100	4	0,045	0,18	0,221%
	GUANTE ESTERIL #7 PERRY/CEGA	3	1,355	4,07	4,999%
	GORRO CIRUJANO DESCARTABLE	3	0,155	0,47	0,577%
	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO X50 UND	5	0,1	0,5	0,614%
10					0,000%
11	MASCARILLA OXIGENO ADULTO SALTER X1	1	1,976	1,98	2,432%
	HALOPERIDOL 5MG/1ML AMP X1 SANDERSON (HALOPERIDOL)	1	0,65	0,65	0,798%
	BUPIROP PESADO 5% AMP X4ML (BUPIVACAINA)	1	3,52	3,52	4,323%
12	ETRON BOTLEPACK 500MG/100ML AMP X1 (METRONIDAZOL)	1	5	5	6,141%
13	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI VARIOS	1	6,683	6,68	8,204%
	HOJA BISTURI#20 BRAUN	1	0,354	0,35	0,430%
	POVIDIN 100ML	1	1	1	1,228%
	OXIGENO QUIROFANO	1	6,8	6,8	8,352%
	VICRYL PLUS 2/0 CT-1 ETHICON	1	5,471	5,47	6,718%
	*FIXOMULL STRECH X 10CM LARGO=1UNID	1	1	1	1,228%
	PLACA PARA PACIENTE CON RETORNO VARIOS	1	5,293	5,29	6,497%
	ETHILON 3/0 SC-20 ETHICON	1	2,554	2,55	3,132%
	VICRYL PLUS 1 CT-1 ETHICON	1	5,218	5,22	6,411%
14	OMEZOL 40MG IV AMPOLLA X1 (OMEPRAZOL)	1	6,504	6,5	7,983%
	KETORODOL 60MG/2ML AMPOLLA X3 (KETOROLACO TROMETAMI	1	3,161	3,16	3,881%
	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP X1 GEN-FAR	1	1	1	1,228%
15					0,000%
16					0,000%
17					0,000%
TOTAL		57	72,55	81,42	100,00%

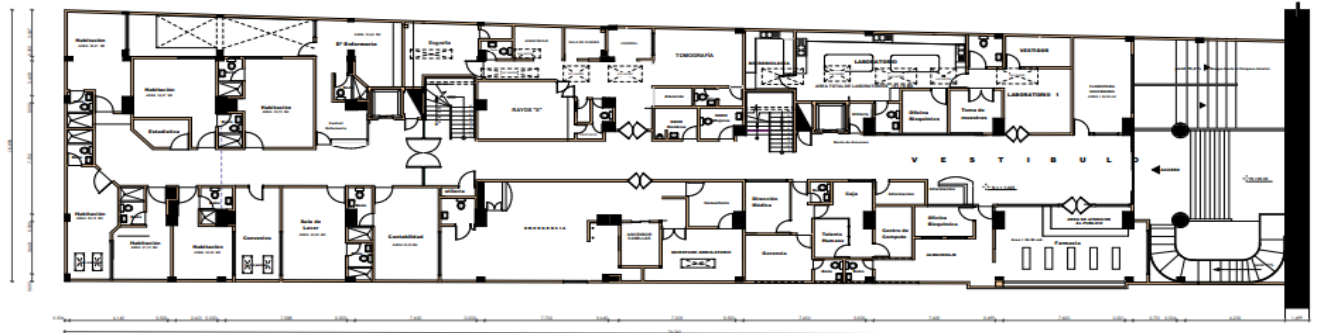
Anexo H: Tiempo de Funcionamiento de las Máquinas

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS			
RECEPCIÓN DEL PACIENTE		Horas (minutos)	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	0,00	0,00%
2.	Verificación de datos del paciente		
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria		
Valoración Pre Quirúrgica			
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0,00	0,00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo		
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano		
Preparación del Quirófano			
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	20	18,18%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano		
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía		
INTERVENCIÓN			
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	90	82%
11.	Intervención del anestesiólogo		
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico		
13.	Realización de la cirugía programada		
Recuperación			
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	0	0
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.		
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.		
17.	El paciente pasa a piso		
TOTAL		110.00	100.00%

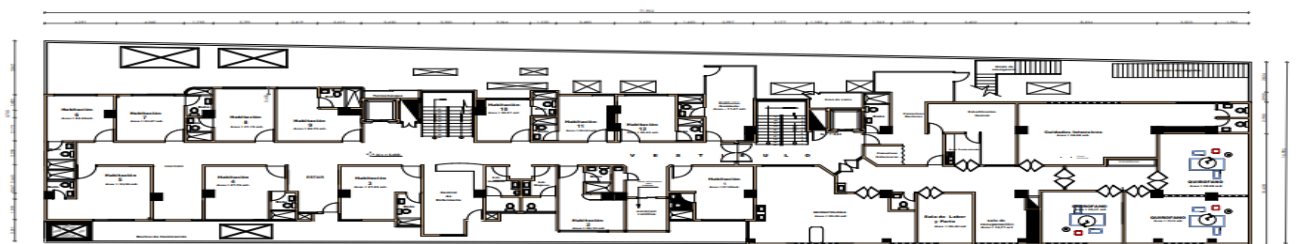
Anexo I: Tiempo de Realización de Actividades de Enfermeras

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENFERMERAS						
RECEPCIÓN DEL PACIENTE		Horas (minutos)	Total minutos	Rep. en Subproceso	Rep. en Total Subprocesos	
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	2,00	10,00	20,00%	5,13%	1,03%
2.	Verificación de datos del paciente	3,00		30,00%		1,54%
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria	5,00		50,00%		2,56%
Valoración Pre Quirúrgica						
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	3,00	15,00	20,00%	7,69%	1,54%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo	3,00		20,00%		1,54%
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano	9,00		60,00%		4,62%
Preparación del Quirófano						
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	5,00	20,00	25,00%	10,26%	2,56%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano	11,00		55,00%		5,64%
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía	4,00		20,00%		2,05%
INTERVENCIÓN						
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	3,00	90,00	3,33%	46,15%	1,54%
11.	Intervención del anestesiólogo	7,00		7,78%		3,59%
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico	5,00		5,56%		2,56%
13.	Realización de la cirugía programada	75,00		83,33%		38,46%
Recuperación						
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	5,00	60,00	8,33%	30,77%	2,56%
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.	30,00		50,00%		15,38%
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.	5,00		8,33%		2,56%
17.	El paciente pasa a piso	20,00		33,33%		10,26%
TOTAL MINUTOS		18,00	195,00		100,00%	100,00%

Anexo J: Costo del Recurso Consideración de los Metros Cuadrados



PLANTA BAJA



PLANTA DE CLINICA Y HOSPITALIZACION
(1ra Planta Alta)

Área de Quirófano



AREA EN M2 DE HOSPITALIZACIÓN			
PLANTA BAJA		PRIMERA PLANTA ALTA	
Area en m2	412.34	Area en m2	1298.5
TOTAL HOSPITALIZACIÓN			1710.84
AREA QUIRÓFANO			240.85

RECURSOS			
ENERGÍA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	DEPRECIACIÓN EDIFICIO
\$2,580.96	\$2,574.84	\$1,554.00	\$65,987.27
\$363.34	\$362.48	\$218.77	\$9,289.61

Anexo K: Número de Personas E Instrumentos que Intervienen en las Actividades

RECEPCIÓN DEL PACIENTE		N. Personas e Instrumentos	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	2.00	12.50%
2.	Verificación de datos del paciente	0.00	0.00%
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria	0.00	0.00%
Valoración Pre Quirúrgica			
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0.00	0.00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo	0.00	
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano	0.00	
Preparación del Quirófano			
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	0.00	0.00%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano	0.00	0.00%
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía	2.00	12.50%
INTERVENCIÓN			
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	0.00	0%
11.	Intervención del anestesiólogo	0.00	
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico	0.00	
13.	Realización de la cirugía programada	0.00	
Recuperación			
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	4.00	25.00%
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la con	0.00	0.00%
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y defi	0.00	0.00%
17.	El paciente pasa a piso	0.00	50.00%
TOTAL		8.00	100.00%

Anexo L: Consumo de Energía de las Máquinas

Descripción	Material	Características	Modelo	Vatios	kilovatios
-------------	----------	-----------------	--------	--------	------------

		Marca			
MAQUINA DE ANESTESIA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 220w. General Electric	9100C	220	0.22
MAQUINA DE ANESTESIA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 220w, 2A General Electric	9100C	220	0.22
MAQUINA DE ANESTESIA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 70w, 2,3A Drager Medical	FABIUS TIRO	70	0.07
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 150w, 3A General Electric	B20	150	0.15
LAMPARA CIELITICA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 160w, 1,45A IMPROMED	INP – 4P MASTER MULTI	160	0.16
LAMPARA CIELITICA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 720w, 6A STERIS	HARMONY LA	720	0.72
LAMPARA CIELITICA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 280w, 2,54A IMPROMED	FOCO DEPLO DUPLO INP – 4X3F	280	0.28
LAMPARA CIELITICA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 120w, 1A IMPROMED	3F MASTER MULTI	120	0.12
ELECTROBISTURI	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 1000w, 9,09A VALLEYLAB	2PCH	1000	1
ELECTROBISTURI	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 1320w, 12A VALLEYLAB	SSE2	1320	1.32
ELECTROBISTURI	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 1000w, 4.5A VALLEYLAB	E-8006	1000	1
EQUIPO DE SELLADO DE VASOS	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 270w, 2.25A VALLEYLAB	LS10	270	0.27
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	SOLAR 8000	36	0.036
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	SOLAR 8000	36	0.036
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	SOLAR 8000	36	0.036
TRAM (MONITOR MULTIPARÁMETROS)	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	TRAM RAC2	36	0.036

TRAM (MONITOR MULTIPARÁMETROS)	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	TRAM-250SL	36	0.036
TRAM (MONITOR MULTIPARÁMETROS)	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36w, 3A General Electric	TRAM-250SL	36	0.036
AUTOCLAVE	ELECTRÓNICO	Semiautomatico, 230v, 10A, 60Hz Tuttnaver	3870EP	2200	2.2
AUTOCLAVE	ELECTRÓNICO	220v, 60Hz, 2.2Kw, 10A Tuttnaver	3870M	2200	2.2
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36Kw, 1.1A Mindray	iMEC12	36000	36
Monitor Multiparámetros.	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 36Kw, 1.1A Mindray	iMEC12	36000	36
Torre de Laparoscopia	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 690w, 6.25A STRYKER	1588 AIM	690	0.69
Torre de Laparoscopia	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 350w, 3.18A General Electric	SC-WU26- AI511	350	0.35
MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 400w, 3.64A MAQUET	1132.11B2	400	0.4
CRANEOTOMO CON PEDESTAL	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 500w, 4.54A MEDTRONIC	E: EC300 P: EF200	500	0.5
ESTERILIZADOR	ELECTRÓNICO	480v, 60Hz, 18Kw, 81.81A SIERIS	HS7-0364	18000	18
ESTERILIZADOR	ELECTRÓNICO	480v, 60Hz, 2.9Kw, 81.81A Tuttnaver	PlazMax P50 - 1R	2900	2.9
BOMBA DE INFUSION	ELECTRÓNICO	Max: 50 Kg - Min: 50g ADE	19180	15	0.015
BOMBA DE INFUSION	ELECTRÓNICO	Max: 50 Kg - Min: 50g ADE	19180	15	0.015
CAMARA TORRE LAPAROSCOPIO	ELECTRÓNICO	110V, 60Hz STRYKER	22220140	85	0.085

CAMARA TORRE LAPAROSCOPIO	ELECTRÓNICO	110V, 60Hz STRYKER	1588 AIM	85	0.085
FUENTE DE LUZ TORRE DE LAPAROSCOPIO	ELECTRÓNICO	110-220V, 60Hz, 350W, 10VCD STORZ	20132020	350	0.35
FUENTE DE LUZ TORRE DE LAPAROSCOPIO	ELECTRÓNICO	110-220V, 60Hz, 350W, 1,3A STRYKER	L10	350	0.35
ELECTROCAUTERIO	ELECTRÓNICO	100-240V, 350W, 20OHM, 2080VA VALLEYLAB	FORCETRIAD	350	0.35
REFRIGERADORA	ELECTRÓNICO	120l, 26KG, 60Hz, 110V, 125kwh DAIWO	FR- 146A1RNW	125000	125
SELLADOR ROTATIVO	ELECTRÓNICO	110V, 60Hz, 11Kg, 26/07/2019 ROTARY SEALER	WRM100-L	1500	1.5
Televisor	ELECTRÓNICO	110v, 60Hz, 110W LG	43UM7360P SA	110	0.11
TOTAL CONSUMO ENERGÍA					232.85

Anexo M: Cantidad de medida de Kilovatios-Hora que Consume cada Actividad

RECEPCIÓN DEL PACIENTE		Kilovatios - hora	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	0.00	0.00%
2.	Verificación de datos del paciente		
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria		
Valoración Pre Quirúrgica			
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0.00	0.00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo		
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano		
Preparación del Quirófano			
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	77.62	18.18%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano		
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía		
INTERVENCIÓN			
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	349.27	82%
11.	Intervención del anestesiólogo		
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico		
13.	Realización de la cirugía programada		
Recuperación			
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	0.00	0.00%
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.		
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.		
17.	El paciente pasa a piso		
TOTAL		426.89	100.00%

REGLA DE TRES	
Hora	Minuto
1	60
1.833333333	110
0.333333333	20
1.5	90

CALCULO DEL KILOVATIO - HORA	
Consumo (Kw)	Horas
232.85	1.833333333

KW- HORA TOTAL	426.88
KW- HORA PREPARACIÓN	77.62
KW- HORA INTERVENCIÓN	349.27

Anexo N: Horas de Consumo de Gases Medicinales en el Quirófano

RECEPCIÓN DEL PACIENTE		Horas (minutos)	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	0.00	0.00%
2.	Verificación de datos del paciente		
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria		
Valoración Pre Quirúrgica			
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0.00	0.00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo		
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano		
Preparación del Quirófano			
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	20	18.18%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano		
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía		
INTERVENCIÓN			
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	90	82%
11.	Intervención del anestesiólogo		
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico		
13.	Realización de la cirugía programada		
Recuperación			
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	0	0
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia		
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.		
17.	El paciente pasa a piso		
TOTAL		110.00	100.00%

Anexo Ñ: Representatividad del Costo de Muebles y Enseres

RECEPCIÓN DEL PACIENTE		%	Costo	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	0.10%	106.07	0.29%
2.	Verificación de datos del paciente	0.10%		
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria	0.10%		
Valoración Pre Quirúrgica				
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0.00%	0.00	0.00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo	0.00%		
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano	0.00%		
Preparación del Quirófano				
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	1.93%	2146.32	5.79%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano	1.93%		
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía	1.93%		
INTERVENCIÓN				
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	10.87%	16122.36	43.49%
11.	Intervención del anestesiólogo	10.87%		
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico	10.87%		
13.	Realización de la cirugía programada	10.87%		
Recuperación				
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	12.61%	18699.12	50.44%
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.	12.61%		
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.	12.61%		
17.	El paciente pasa a piso	12.61%		
TOTAL		100.00%	37073.87	100.00%

Anexo O: Representatividad del Costo de Máquina, Equipo y Tecnología

RECEPCIÓN DEL PACIENTE		%	Costo	Representatividad
1.	Recepción del paciente prequirúrgico	0.00%	0.00	0.00%
2.	Verificación de datos del paciente	0.00%		
3.	Elaboración de lista de Verificación Pre-Operatoria	0.00%		
Valoración Pre Quirúrgica				
4.	Ingreso del paciente al quirófano y entrega al anestesiólogo	0.00%	0.00	0.00%
5.	Comunicación del diagnóstico del paciente al anestesiólogo	0.00%		
6.	Evaluación y monitoreo del paciente en el área de quirófano	0.00%		
Preparación del Quirófano				
7.	Preparación de equipos necesarios para la cirugía	6.67%	78021.77	20.00%
8.	Dotación de materiales e insumos necesarios en el quirófano	6.67%		
9.	Preparación del personal a intervenir en la cirugía	6.67%		
INTERVENCIÓN				
10.	Verificación de datos generales previo a la operación	20.00%	312114.15	80.00%
11.	Intervención del anestesiólogo	20.00%		
12.	Intervención del cuerpo clínico y médico quirúrgico	20.00%		
13.	Realización de la cirugía programada	20.00%		
Recuperación				
14.	Ingreso a la sala de post Operatorio	0.00%	0.00	0.00%
15.	Se monitoriza paciente hasta su estabilización, recuperación de la conciencia y movimientos.	0.00%		
16.	El médico tratante (anestesiólogo) autoriza egreso del paciente y define ruta.	0.00%		
17.	El paciente pasa a piso	0.00%		
TOTAL		100.00%	390135.92	100.00%

Anexo P: Central de Cirugía- Quirófanos



Anexo Q: Protocolo del Proyecto integrador



Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría

"Aplicación del Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios"

Protocolo del Trabajo de titulación, modalidad: Proyecto Integrador

Autor:

Denisse Andrea Méndez Orellana

CI:0150221398

Autor:

Camila Michelle Pallango Astudillo

CI: 0107340754

Tutor:

CPA. Marco Peralta Zúñiga.

CI: 0104657994

Cuenca, Ecuador

08-mayo-2023

Índice

1. Pertinencia académico-científica y social.....	4
1.1 Pertinencia Académica.....	4
1.2 Pertinencia Científica.....	4
1.3 Pertinencia Social	5
2. Justificación.....	5
3. Problema Central	7
4. Objetivos	8
4.1 Objetivos Generales	8
4.2 Objetivos Específicos.....	8
5. Marco teórico	9
5.1 Definición Costos	9
5.2 Contabilidad de Costos	9
5.2.1. Concepto.....	9
5.2.2. Importancia	9
5.2.3. Objetivos	10
5.3 Elementos del Costo	10
5.3.1. Materia Prima.....	10
5.3.2. Mano de Obra	11
5.3.3. Costos indirectos de fabricación.....	11
5.4 Sistemas de Costeo.....	11
5.4.1. Costeo por procesos	11
5.4.2. Costeo por órdenes de producción.....	11
5.4.3. Costeo ABC	11
5.5 Sistema de costos Basado en Actividades ABC	12
5.5.1. Concepto.....	12
5.5.2. Objetivos	12
5.5.3. Definiciones básicas del modelo	13
5.5.4. Proceso.....	14
5.5.5. Ventajas y desventajas	15
6. Diseño Metodológico.....	16
6.1 Tipo de Investigación	16
6.2 Método de investigación	17

7. Cronograma de Actividades.....	1
8. Esquema Tentativo.....	1
9. Bibliografía.....	3

1. Pertinencia académico-científica y social

1.1 Pertinencia Académica

A lo largo de la formación académica universitaria en la carrera de Contabilidad y Auditoría se alcanzan útiles y valiosos conocimientos que guiarán el presente trabajo de titulación. El proyecto integrador aborda desde un punto de vista académico la aplicación de distintas áreas de conocimiento involucradas para su desarrollo como: Contabilidad de Costos, Contabilidad General, Presupuesto del Sector Privado, Metodología de la Investigación. Dichas áreas serán herramientas aprovechadas y desarrolladas en la consecución de la Aplicación del Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios", de esta manera se pondrá en práctica ya su vez se expondrá las destrezas adquiridas.

1.2 Pertinencia Científica

Con relación al ámbito científico, la metodología en la que girará el desarrollo de este trabajo será una investigación descriptiva analítica con un enfoque mixto, es decir se analizará datos cualitativos y cuantitativos mediante la recaudación de información de fuentes primarias con el objetivo de conocer y comprender de forma precisa las distintas actividades que se ejecutan en los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.

Para la recolección de los datos cuantitativos se apoyará en la información proporcionada por la empresa para su posterior análisis y aplicación del modelo de costos basado en actividades (ABC). En cuanto a la perspectiva cualitativa se obtendrán en técnicas tales como entrevistas y observación directa de los procesos que se desarrollan en el área.

Dentro del contexto empresarial en la que se encuentra y debido a la actividad que desempeña la organización se ha determinado la aplicación del Modelo de Costos Basado en Actividades ABC dado el alcance, la metodología y las ventajas aplicativas evidentes que significan. Para (Zapata Sánchez, 2019) "...resulta indispensable dividir la empresa en actividades." Considera que la función esencial de una actividad es transformar recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en resultados cuantificables. (Zapata Sánchez, 2019)

Además, es conveniente su implementación cuando la actividad de económica es comercial, industrial o de servicios, cuente con un sistema informático completo, confiable, e interrelacionado que procese y capture información oportunamente, tener una magnitud considerable de costos indirectos y que estos puedan asignarse adecuadamente, gozar de un vasto surtido de productos o

servicios y poseer una importante inversión inicial de recursos monetarios y tiempo. (Zapata Sánchez, 2019)

1.3 Pertinencia Social

Desde el punto de vista social, el trabajo de titulación busca contribuir con herramientas eficientes, necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades del Hospital. Al ser el área de quirófano una de las más representativas por su volumen de ingresos, permitirá que la entidad pueda mejorar la asignación de los recursos y evitar desperdicios, beneficiando con la optimización de los costos de las intervenciones médicas y determinando precios adecuados y accesibles a los pacientes de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.

2. Justificación

ASOGALENICA S.A "Hospital San Juan de Dios" tiene 9 años de creación y vigencia en el mercado farmacéutico y hospitalario, dentro de su sector, se ubica entre las diez empresas que mayores ingresos generan en el Azuay. No obstante, a pesar de su tamaño y representatividad aún no cuenta con una metodología clara para la determinación de costos en sus servicios de hospitalización. Dichos servicios representan el 83% del total de los ingresos, que en promedio (considerando los últimos 3 años) ascienden a 3.500.000,00 USD. Adicionalmente, el hospital no cuenta con procesos debidamente levantados y formalizados, lo cual dificulta la erogación de recursos y su respectivo seguimiento. La alta dirección considera que se podría mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y eficacia a través de la aplicación de un sistema de costos que se ajusten a las necesidades del hospital.

Después de un análisis exhaustivo de la situación de la compañía y una revisión preliminar de los elementos del costo que podría englobar un servicio hospitalario, se llegó a la conclusión de que es prudente aplicar el Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC), por las siguientes razones (Duque y Osorio, 2003):

- El peso de los Costos Indirectos de Fabricación sobre el Total de Costos es representativo.
- El mercado es muy competitivo, los precios de los servicios están constantemente reduciéndose.
- Variedad de servicios que se ofrecen.

Los gastos operativos son estructurales y demandan de cambios estratégicos para cambiarlos.

Adicionalmente, se ha constatado que el hospital cumple con las premisas del Sistema de Costos ABC, que son (Gosselin, 2007):

- Los servicios demandan actividades para su ejecución.
- Las actividades exigen recursos para su realización.
- Los recursos demandan erogación monetaria para su consumo.

Por lo anteriormente mencionado, se ha conversado con el Gerente del hospital que el Sistema de Costos que se ajusta a sus necesidades es el Costeo Basado en Actividades (ABC), el cual ha sido aceptado y validado para su aplicación.

3. Problema Central

ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios tiene como objeto social brindar todos los servicios relacionados con la salud en general y particularmente la prestación de servicios médico quirúrgicos y de especialidades, mediante facultativos especializados, previa calificación de su idoneidad y capacidad (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, 2023).

Actualmente la empresa ofrece diversos servicios hospitalarios dentro de las áreas del hospital como, por ejemplo: Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, Quirófano, Laboratorio, Imagenología, Farmacia, entre otros, mismas que desde hace unos años han venido creciendo y desarrollándose para constituirse en una de las empresas más grandes de la ciudad de Cuenca debido a su nivel de ingresos y personal capacitado, además de su competitividad y rentabilidad en el mercado.

Sin embargo, se ha tenido el conocimiento de que el Hospital a pesar de su tamaño y nivel de operaciones no cuenta con procesos formalizados relacionados a un sistema de costos interno que le permita determinar y administrar de manera eficiente los costos de la cartera de servicios que ofrece, de manera que se ha empleado como único recurso la experiencia y sin ningún análisis profundo, llevando a cabo una técnica empírica.

Al prestar el servicio se debe tomar en cuenta el requerimiento de diferentes equipos, instrumentos e insumos necesarios para poder establecer el precio al público. Es allí donde la problemática genera un impacto mayor, ya que los costos establecidos no reflejan el valor económico real de los egresos, y por ende no se tiene una apreciación verídica de las utilidades obtenidas.

Esta consecuencia desencadena en dificultades para la Gerencia en la toma de decisiones y el planteamiento de planes estratégicos enlazados directamente con la asignación de recursos y gestión de costos y gastos.

4.Objetivos

4.1 Objetivos Generales

Determinar los costos de los servicios de hospitalización: Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios a través del sistema de costeo basado en actividades (ABC) de manera que se proporcione una herramienta para el manejo eficiente y eficaz de los recursos.

4.2 Objetivos Específicos

1. Elaborar un análisis situacional de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.
2. Identificar los principales procesos llevados a cabo en el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios.
3. Asignar de los costos para cada actividad desarrollada en el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A Hospital San Juan de Dios a los objetos de costo mediante inductores.
4. Determinar los costos totales y unitarios para cada actividad dentro del área de Quirófano

5.Marco teórico

5.1 Definición Costos

Los contadores definen el costo como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo específico. Un costo (como los materiales directos o la publicidad) por lo general se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios (HORNGREN, 2012).

5.2 Contabilidad de Costos

5.2.1 Concepto

Para LAMBRETÓN TORRES & GARZA FERNÁNDEZ (2016) la contabilidad de costos se describe como la disciplina contable dedicada a categorizar, examinar, acumular, supervisar y asignar costos a los procesos, actividades o servicios, con el objetivo de obtener mediciones independientes para la empresa. De igual manera Sánchez Barraza (2009) menciona que la contabilidad es aquella que se encarga de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos dirigido hacia un objeto de costo.

5.2.2 Importancia

La contabilidad de costos nos proporciona información relevante concerniente a los procesos propios de una organización. Al formar parte de un sistema general, como un subsistema, generalmente aplicado en empresas industriales, pero no exento para otros tipos de empresas,

permite discernir cuál ha sido la inversión en la transformación de un producto. Sus criterios válidos pueden ser de aplicación para empresas de varios sectores de la economía como por ejemplo el sector agrícola, pecuarios, de alimentos, incluso puede determinar el costo de un servicio (Marulanda Castaño, 2009).

Mediante la información que brinda se puede comprender cuáles de los productos o servicios que ofrece la empresa son rentables, de esta manera puede gozar de una ventaja sobre la competencia en el mercado. Además, se considera que es importante ya que ayuda en una gestión suficiente y adecuada de los recursos y así evitar la sobreutilización de los mismos, convirtiéndose en una herramienta importante para la toma de decisiones de las empresas (Villegas et al., 2004).

5.2.3 Objetivos

La contabilidad de costos tiene como objetivo tres puntos relevantes 1) Proporcionar información con el fin de evaluar las existencias. 2) Generar información que ayude en la planificación y control de control de las operaciones de la entidad. 3) Facilitar información sobre los costos para que la dirección tome decisiones informadas y estratégicas (Lazo Palacios, 2013).

Por otra parte, según Balanda (2005) los objetivos son la 1) Clasificación, tanto de productos o servicios a partir de conductas recurrentes, actividades y procesos en los cuales están vinculados. 2) Acumulación, por cuentas, trabajos, procesos u otras secciones. 3) Asignación de costos, a los distintos procesos o actividades que intervienen en la fabricación de un bien o servicios.

5.3 Elementos del Costo

5.3.1 Materia Prima

Comprendido como uno de los principales componentes, ya sea que se encuentren en su estado original o no, intervienen directamente en la producción de un bien o un servicio (Zapata Sánchez, 2019).

5.3.2 Mano de Obra

Considerada como la fuerza física o mental del ser humano, es empleada en la transformación de la materia prima, ya sea con ayuda de máquinas, equipos y tecnología (Zapata Sánchez, 2019).

5.3.3 Costos indirectos de fabricación

Son aquellos costos independientes que complementan a los procesos, pero no intervienen con los productos o servicios terminados (Zapata Sánchez, 2019).

5.4 Sistemas de Costeo

5.4.1 Costeo por procesos

Forma parte del sistema de acumulación de costos, se ejecuta a través de centros de costos creados para cada departamento, en los cuales se da una producción masiva y de manera constante (Zapata Sánchez, 2019).

5.4.2 Costeo por órdenes de producción

Este sistema es usado por empresas en donde se realizan procesos discontinuos, es decir que se realiza en intervalos de tiempo cierta cantidad de producto, ya sea por unidad, lote o cualquier acumulación de existencias (Lazo Palacios, 2013).

5.4.3 Costeo ABC

Se basa en desarrollar la acumulación de costos con base en las actividades que se efectúan dentro de los distintos procesos incurridos en una organización. Se refiere a una acumulación de costos más detallada que los anteriores sistemas mencionados, y además recientemente promovida por los creadores del Costeo Basado en Actividades (Cuervo Tafur et al., 2013).

5.5 Sistema de costos Basado en Actividades ABC

5.5.1 Concepto

Con base en HORNGREN (2012) la mejor forma de enriquecer un sistema de costos es implementando el costeo basado en actividades ya que este sistema se conceptualiza como la identificación de actividades, tareas o unidades de trabajo que poseen un objetivo en específico desarrolladas en una empresa, es decir de todas las funciones relativas a la cadena de valor, posterior asignan los costos al objeto referente o acumulativo de costos.

5.5.2 Objetivos

Según Zapata Sánchez (2019) los objetivos fundamentales del costeo basado en actividades son:

- Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y procesos de la empresa, optimizando el uso de recursos y orientando la organización hacia el mercado.
- Ser una medida del desempeño, que permita mejorar los objetivos de satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas y administrativas.
- Proporcionar información para la planeación del negocio, determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas.

- Integrar toda la información necesaria para llevar adelante la empresa. Así, las organizaciones pueden extender la administración de costos para que reflejen las actividades mediatas como la fabricación, ventas, finanzas, procesos, etc.

Como podemos ver este sistema tiene como finalidad proporcionar una visión más clara acerca de las actividades y buscar una mejora continua en cada una de ellas estableciendo costos más reales y detallados.

5.5.3 Definiciones básicas del modelo

Recursos

Los recursos son los medios utilizados para el desarrollo de las actividades, estos cumplen diversas funciones y características semejantes, así también se les asigna un valor adecuado garantizando un consumo fiable dentro de la organización. Para el Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC) los recursos van a depender del tamaño y a lo que se dedica la empresa, ya que de esta manera se podrá asignar e identificarlos oportunamente a cada actividad, y así los inductores destinarlos a su objeto de costos (Zapata & González, 2019).

Actividad

La actividad es una tarea o proceso que se realiza con el fin de cumplir un objetivo. Dentro del Sistema ABC las actividades son una parte medular que se deben identificar, porque facilitan la información para la toma de decisiones. Es importante mencionar que las actividades son elementos imprescindibles para el desarrollo de la cadena de procesos de una organización que tienen como finalidad la producción de un bien o la generación de un servicio. Dentro de las actividades se lleva a cabo la determinación y asignación de costos (Horngren et al., 2010).

Inductores

El cost driver o inductor en el sistema ABC es un elemento clave, permite que se pueda identificar de mejor manera los componentes y aspectos que intervienen dentro de las actividades, tales como criterios financieros o no financieros que conlleva a los costos indirectos a ser distribuidos en el producto o servicio (Zapata Sánchez, 2019).

Estos indicadores serán beneficiosos siempre y cuando cumplan tres aspectos importantes:

- Que la información de los costos debe ser continua y que pueda ser comparable entre un año y otro.

- La información debe ser pertinente, de manera que pueda responder oportunamente a los sucesos que se presenten en los inventarios.
- Que sea cuantificable, ya que, con la generación de los datos proporcionados, se asignan los costos y se pueden hacer las distribuciones a cada actividad.

Proceso

Para el diseño de un Sistema de Costos Basado en Actividades Tirado Valencia (2003) plantea las siguientes fases:

1. **Determinación del costo de las actividades. Definición de los inductores de recursos.** Al contar con las actividades identificadas se debe establecer un costo para cada una. Es necesario fijar criterios o parámetros adecuados que figuran el consumo de los recursos que se ejecuta en cada actividad o inductor de recursos.
2. **Definición de los centros de actividad.** Es preciso crear conjuntos de actividades que tengan fines similares, y de esta forma se pueda obtener información de las agrupaciones. Un ejemplo de las agrupaciones podrían ser aquellas actividades efectuadas por un departamento o también las relacionadas con un proceso. A las agrupaciones se las puede denominar como centros de actividad.
3. **Definición de las medidas de la actividad.** A través de la medición de la actividad, el costo de las actividades se atribuye a los objetos de costo. De las medidas aplicadas dependerá la exactitud e integridad.
4. **Determinación del costo de los objetos de costo.** Previo a un análisis preliminar de la definición de los objetos de costo, las actividades se irán encaminando a los objetos de costos respectivos y así se les atribuye el costo de las actividades que consumen mediante las medidas de la actividad.

5.5.5 Ventajas y Desventajas

Ventajas

- La revisión y corrección de los cálculos en las empresas con bases más justas y precisas (ya que los indirectos se distribuyen con base en lo que realmente los genera). En casos excepcionales, el sistema confirma que el costeo tradicional estuvo bien aplicado (Calleja Bernal, 2013).
- Pueden generar una gestión de controles incurridos en los costos, un conocimiento más amplio y específico de las actividades que generan costos y ver cuáles consumen recursos (Brito Lared, Ferreira Martínez, & López Castañeda, 2019).

- Puede servir como herramienta para la creación de una base de datos que contenga información que ayude en cuanto a implementación de procesos, control de calidad, que ayuden a evitar, o gestionar los problemas (Brito Lared, Ferreiro Martínez, & López Castañeda, 2019).
- Se puede implementar tanto en empresas de producción como en servicios (Brito Lared, Ferreiro Martínez, & López Castañeda, 2019).

Desventajas

Teniendo en cuenta a Renjifo (2013) las desventajas pueden comprender las siguientes:

- Pueden existir limitaciones con respecto al nivel de detalle que abarca. En ocasiones los detalles suelen llegar a ser excesivos y convertirse en innecesarios o contener datos pobres y dirigirlos al fracaso.
- Con la aparición de algún percance puede llegar a causar una tergiversación en la selección de las actividades y del sistema contable, y con esto interferir negativamente en los resultados.
- Es necesario un alto grado de juicio profesional en la aplicación del sistema ABC, debido a que no se puede aplicar aisladamente de otros modelos de gestión de costos y requiere de contemplaciones y mediciones precisas.
- La utilización de la inversión de costos se aplica estratégicamente en situaciones beneficiosas para la empresa, como en el caso de disqueras o editoriales, en las cuales conscientemente un producto exitoso financia a otros que no tienen tanto éxito (Calleja Bernal, 2013).

6. Diseño Metodológico

6.1 Tipo de Investigación

Para la realización del trabajo de titulación se ha optado por aplicar un tipo de investigación descriptiva analítica con un enfoque cualitativo y cuantitativo.

Al referirnos al tipo de investigación descriptiva nos permitirá obtener un detalle pormenorizado de los costos relativos a las actividades desarrolladas en el Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, mediante la recolección, ordenación y análisis de datos, para alcanzar un conocimiento amplio y con ello poder establecer el modelo de Costeo Basado en Actividades ABC y generar un detalle sobre la aplicación del mismo.

Con respecto al método analítico, podemos decir que nos posibilitará la comprensión y discernimiento de la información proporcionada por la administración y las áreas involucrada con las actividades que pertenecen al Área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, de manera que nos permita relacionar y aplicar con el modelo de costo anteriormente mencionado.

Método de investigación

En cuanto al método de investigación que se va a llevar a cabo durante el trabajo de investigación será el método cuantitativo y cualitativo con referencia a un caso de estudio en ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios.

Una de las características que comprende el método cuantitativo es la recolección de datos, los mismos que serán proporcionados por el sistema contable, la administración y las áreas involucradas con el área de Quirófano de ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios, posteriormente se procederá a la medición y análisis de los datos basado en el modelo planteado (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

Por último, mediante el método cualitativo se plantea alcanzar conocimientos amplios acerca de la organización y en específico el área en cuestión, utilizando técnicas como entrevistas abiertas, revisión de documentos, e interacción e introspección (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

7.Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																												
ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
	SEMANAS																																											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Presentación del Tema		X																																										
Aprobación del Tema							X																																					
Elaboración del Protocolo del Proyecto Integrado								X																																				
Presentación y Aprobación del Protocolo Unidad de Titulación									X																																			
DESARROLLO DEL PROYECTO																																												
ELABORACION DEL CAPITULO I: Aspectos generales sobre ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios												X																																
Sustentación ante el grupo de expertos el Protocolo de Trabajo de Titulación aprobado												X																																
REVISION Y CORRECCION DEL CAPITULO I: Aspectos generales sobre ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios													X																															
ELABORACIÓN CAPITULO II: Marco Teórico													X																															
Presentación del trabajo de titulación con un avance de por lo menos el 25%														X																														
ELABORACIÓN CAPITULO III: Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios"																				X	X	X	X	X	X																			
REVISIÓN Y CORRECCIÓN CAPITULO III: Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios"																									X																			
Resumen																												X																
Abstract																													X															
Índice																																			X									

Denisse Andrea Méndez Orellana – Camila Michelle Pallango Astudillo

8. Esquema Tentativo

ESQUEMA TENTATIVO	
A	Resumen
B	Abstract
C	Índice
D	Reconocimiento de los derechos de autor
E	Reconocimiento de responsabilidad
F	Agradecimiento y dedicatoria
G	Introducción
H	Justificación
I	Planeamiento del problema
J	Objetivos
J.1	Objetivo general
J.2	Objetivos específicos
K	Diseño metodológico
K.1	Tipo de investigación
K.2	Método de investigación
CAPITULO I	Aspectos generales sobre ASOGALENICA S.A. Hospital San Juan de Dios
1.1	Reseña histórica de la organización
1.2	Ubicación geográfica
1.3	Misión
1.4	Visión
1.5	Objetivos institucionales
1.6	Valores y principios
1.7	Estructura organizacional de la empresa.
1.8	Políticas culturales
1.9	Los Insumos médicos del área de Quirófano
1.9.1	Gestión de Atención y entrega de medicina
1.9.2	Alcance
CAPITULO II	Marco teórico
2.1	Definición de Costos
2.2	Contabilidad de costos
2.3	Objetivos de la contabilidad de costos
2.4	Elementos del costo
2.4.1	Materia Prima
2.4.2	Mano de Obra
2.4.3	Costos Indirectos de Fabricación
2.5	Sistema de costos
2.5.1	Costeo por procesos
2.5.2	Costeo por ordenes
2.5.3	Costeo ABC
2.6	Sistema de Costos Basado en Actividades ABC
2.6.1	Concepto
2.6.2	Objetivos

2.6.3	Definiciones Básicas del modelo
2.6.3.1	Recursos
2.6.3.2	Actividad
2.6.3.3	Inductores
2.6.4	Proceso
2.6.5	Ventajas y Desventajas
2.6.5.1	Ventajas
2.6.5.2	Desventajas
CAPITULO III	Sistema de Costos ABC para el Área de Quirófano en ASOGALENICA S.A. "Hospital San Juan de Dios"
3.1	Diseño del modelo ABC del área de Quirófano
3.1.1	Localización de los centros de costos del área de quirófano
3.1.2	Identificación y clasificación de las actividades
3.1.3	Distribución de los costos de las actividades
3.1.4	Elección de los generadores de costos
3.1.5	Reclasificación y reagrupación de actividades
3.1.6	Cálculo del costo unitario del generador de costo
3.1.7	Asignación de los costos de los productos de las actividades al servicio
3.1.8	Asignación de los costos directos al servicio
3.2	Costos indirectos del área de Quirófano
CAPITULO IV	Conclusiones y recomendaciones
L	Bibliografía
M	Anexos

9.Referencias

- Balanda, T. (2005). UNIVERSIDAD NACIONAL de MISIONES FACULTAD de CIENCIAS ECONÓMICAS DEPARTAMENTO de CONTABILIDAD CONTABILIDAD de COSTOS PARTE II-Los Factores del Costo PARTE III- Métodos y Sistemas de Costos.
- Brito Lared, J., Ferreiro Martínez, V. V., & López Castañeda, C. E. (2019). SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES EN LA FABRICACIÓN DE CAMPANAS INDUSTRIALES: APLICACIÓN DEL MODELO ABC COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN. *Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración*, 33.
- Cuervo Tafur, J., Osorio, J. A., & Duque Roldán, M. I. (2013). *Costeo basado en actividades ABC: Gestión basada en actividades ABM*. Ecoe Ediciones.
- Calleja Bernal, F. J. (2013). *COSTOS* (Segunda). Pearson.
- Duque, M.I., Osorio, J.A. (2003). Sistema de costeo basado en actividades aplicado al sector
- salud. Revista Contaduría Universidad de Antioquia, número 43, julio-diciembre.
- Gosselin, M. (2007). A Review of Activity-Based Costing: Technique, Implementation and Consequences. En Chapman, Hopwood y Shields (Eds.), *Handbook of Management Accounting Research* (pp. 641-671). Elsevier.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*. México: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- HORNGREN, C. T. (2012). *Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial* (Decimocuarta edición ed.). México: PEARSON EDUCACIÓN.
- LAMBRETÓN TORRES, V., & GARZA FERNÁNDEZ, G. (2016). *Costos para la toma de decisiones* . México: PEARSON EDUCACIÓN.

- Lazo Palacios, M. (2013). *Contabilidad de los Costos I*. Editorial Imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión.
- Marulanda Castaño, O. J. (2009). *CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS*. Obtenido de UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA: <https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-44-Curso-costos-y-presupuestos.pdf>
- Renjifo, M. (2013). Principales Elementos del Sistema de Costeo ABC e Introducción al ABM. *REVISTA LIDERA*, 4.
- Recalde, J. T., & Porporato, M. (2021). Costos Basados en las Actividades (ABC): Aplicación de una herramienta para la gestión estratégica en empresas de servicios. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, 17(32). <https://www.redalyc.org/journal/4096/409668434001/html/>
- Sánchez Barraza, B. J. (2009). PROBLEMÁTICA DE CONCEPTOS DE COSTOS Y CLASIFICACIÓN. *QUIPUKAMAYOC | Revista de la Facultad de Ciencias Contables*, 10.
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS. (2023). *PORTAL DE INFORMACIÓN / CONSULTA DE COMPAÑÍA*. Obtenido de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS: <https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/societario/busquedaCompanias.jsf>
- Tirado Valencia, P. (2003). *GESTIÓN DE COSTES Y MEJORA CONTINUA. Los sistemas de costes y de gestión basados en las actividades (ABC-ABM)* (Primera). Desclée de Brouwer, S.A.
- Villegas, C. F. C., Chávez, G., Castillo, J. A., Caicedo, N. M., & Solarte, W. F. (2004). *COSTEO ABC. ¿POR QUÉ Y CÓMO IMPLANTARLO?* 92.

- Zapata, R. A. E., & González, B. P. (2019). *COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES (ABC): ANÁLISIS DE LOS FACTORES CLAVES IDENTIFICADOS EN LAS INVESTIGACIONES DESARROLLADAS.*